

Plano de Emergência para a Saúde

Editores

Aida Isabel Tavares, ISEG, UL, Professora Associada

atavares@iseg.ulisboa.pt

Eduardo Costa, IST, UL, Professor Auxiliar

eduardo.a.costa@tecnico.ulisboa.pt

Autores

Ana Margarida Canelas

Bárbara Sofia Ferreira

Fábio Batista Pereira

Filipa Oliveira Gonçalves

Filipa Isabel Costa

Francisco Silva Ribeiro

Inês Alegre Santos

Inês Sofia Rodrigues

João Parreira Coucelo Martins

Maria Alexandra Cabeleira

Maria Cortes Ferreira

Ricardo Pereira Dias

Sara Fonseca Lopes

Tiago António

Policy Briefs

A série de *Policy Briefs* do Institute of Public Policy pretende apoiar o debate público com trabalhos curtos, claros e acessíveis, onde se analisam e explicam conceitos, desafios ou medidas concretas de políticas públicas de forma rigorosa.

Sobre o Institute of Public Policy

O Institute of Public Policy é um *think tank* independente, sob a forma de associação sem fins lucrativos, cuja missão é contribuir para a melhoria da análise e do debate público das instituições e políticas públicas em Portugal e na Europa, através da criação e disseminação de investigação.

Índice

Introdução.....	6
Enquadramento académico.....	6
<i>Perspetiva do Plano de Emergência para a Saúde</i>	7
Conclusão	8
Agradecimentos	9
Eixo Estratégico 1 Resposta a Tempo e Horas	10
1. Contextualização do problema	10
2. Apresentação sumária das medidas.....	11
<i>Medida A.1 Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024</i>	11
<i>Medida B.3 Reforço do acesso à consulta especializada</i>	12
<i>Medida C.5 Monitorização de acompanhamento à atividade adicional</i>	12
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica.....	13
<i>Medida A.1 Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024</i>	13
<i>Medida B.3 Reforço do acesso à consulta especializada</i>	14
<i>Medida C.5 Monitorização de acompanhamento à atividade adicional</i>	14
4. Rever ou reforçar as medidas propostas	15
<i>Medida A.1 Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024</i>	15
<i>Medida B.3 Reforço do acesso à consulta especializada</i>	16
<i>Medida C.5 Monitorização de acompanhamento à atividade adicional</i>	17
5. Considerações finais	17
Referencias	19
Anexos	19
Eixo estratégico 2 Bebés e Mães em Segurança.....	21
1. Contextualização do problema	21
2. Apresentação sumária das medidas.....	23
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica.....	24
<i>A.1 Criação de canal de atendimento direto para a grávida, alavancando na linha SNS 24 (SNS Grávida)</i>	24
<i>B.2 Atualização dos rácios de pessoal e da composição das equipas nos locais de parto em função de critérios técnico-científicos atendíveis</i>	25
<i>C.3 Estabelecimento de novas estruturas organizacionais para blocos de parto/obstetrícia</i>	26
4. Rever ou reforçar as medidas propostas	27
Referencias	29
Eixo estratégico 3 Cuidados Urgentes e Emergentes	30
1. Contextualização do problema	30
2. Apresentação Sumária das Medidas	31
<i>A.1 Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica</i>	31

A.2 Criação de Centros de Atendimento Clínico (CAC) para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica	31
A.3 Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência	32
B.2 Criação da Especialidade de Médica de Urgência	32
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	32
A.1 Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica	32
A.2 Criação de Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica	33
A.3 Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência	34
B.2. Criação da Especialidade de médica de Urgência	34
4. Rever ou reforçar as medidas propostas	34
A.1 Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica	35
A.2 Criação de Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica	36
A.3 Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência	38
B.2 Criação da Especialidade de Médica de Urgência	38
Referencias	40
Eixo Estratégico 4 Saúde Próxima e Familiar	41
1. Contextualização do problema	41
2. Apresentação sumária das medidas	42
Medida A.1 Afetação de Médicos de Família aos utentes em espera com a capacidade atual do setor público	42
Medida A.2 Reforço da resposta pública dos Cuidados de Saúde Primários em parceria com o setor social	42
Medida A.3 Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Parceria Público-Privada com Hospital de Cascais)	43
Medida A.4 Criação de linha de atendimento para utentes que necessitem de acesso a médico no dia	43
Medida B.1 Implementação de USF-modelo C	43
Medida B.2 Reforço da resposta pública com médicos aposentados	44
Medida B.3 Revisão dos critérios de transição de USF-modelo A e UCSP e para USF-modelo B	44
Medida B.4 Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Associações de Médicos e Cooperativas)	44
Medida B.5 Incentivo à adesão ao regime voluntário de carteira adicional de utentes	45
Medida C.1 Disponibilização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica em química seca e radiologia convencional	45
Medida C.2 Dinamização de rastreios oncológicos nos Cuidados de Saúde Primários	45
Medida C.3 Criação de Centros de Avaliação Médica e Psicológica	46
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	46

<i>Medida A.3 Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Parceria Público-Privada com Hospital de Cascais)</i>	46
<i>Medida B.3 Revisão dos critérios de transição de USF-modelo A e UCSP, para USF-modelo B</i>	46
<i>Medida C.1 Disponibilização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica em química seca e radiologia convencional</i>	47
4. Rever ou reforçar as medidas propostas – comentário.....	48
Referencias	50
Anexos	51
Eixo Estratégico 5 Saúde Mental	53
1. Contextualização do problema	53
2. Apresentação sumária das medidas.....	55
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica.....	56
<i>O Mercado da Saúde Mental: Relação Oferta - Procura</i>	57
<i>Avaliação Económica do Impacto das Medidas</i>	57
<i>Modelos de Financiamento – Relação de Agência nos Cuidados de Saúde Mental</i>	58
4. Revisão ou Reforço das medidas propostas.....	60
<i>Intervenção em Grupos Profissionais – Critérios e Custo de Oportunidade</i>	60
<i>Monitorização de Resultados e Tomada de Decisões sobre Projetos-Piloto</i>	61
<i>Definição de Estratégias para o Estigma e Iliteracia como Barreiras ao Acesso</i>	62
<i>Abordar o Papel dos Cuidadores Informais para o Sucesso do Plano</i>	62
Comentário Final.....	64
Referencias	67

Sumário Executivo

O Plano de Emergência da Saúde foi apresentado em maio de 2024, pelo Ministério da Saúde. Este plano é um instrumento de política de saúde que visa enfrentar desafios urgentes e prioritários no acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Estruturado em cinco eixos estratégicos, o plano propõe um conjunto abrangente de medidas que respondem às necessidades críticas atuais do sistema de saúde. Cada eixo estratégico foi objeto de análise por um grupo de profissionais de saúde que resultaram na elaboração de *Policy Briefs* que resumem as principais recomendações e direções de ação. Estes documentos apresentam também uma análise crítica às medidas implementadas e propõem possíveis melhorias na sua implementação. Os cinco eixos estratégicos e correspondentes *Policy Briefs* são os seguintes:

Eixo Estratégico 1 Resposta a Tempo e Horas	10
Eixo estratégico 2 Bebés e Mães em Segurança	21
Eixo estratégico 3 Cuidados Urgentes e Emergentes.....	30
Eixo Estratégico 4 Saúde Próxima e Familiar	41
Eixo Estratégico 5 Saúde Mental	53

Introdução

Enquadramento académico

Este documento de trabalho designado “Plano de Emergência para a Saúde: 5 Policy Briefs” foi realizado no âmbito da unidade curricular Economia e Política da Saúde (EPS) da pós-graduação de Gestão das Instituições de Saúde (GIS), 3ª Edição, do ISEG Executive Education, durante os meses de maio-julho de 2024.

Com base nos conhecimentos de Economia da Saúde discutidos, a turma da referida pós-graduação foi desafiada apresentar uma análise ao recém-publicado Plano de Emergência para a Saúde (PES). Este plano foi apresentado pelo Ministério da Saúde, sob a direção da Ministra da Saúde Ana Paula Martins, no seguimento do previsto no Programa do XXIV Governo Constitucional.

O grupo que frequentou esta edição do GIS inclui 13 formandos, dos quais 9 são mulheres; a média de idade ronda os 34 anos, num intervalo de idades dos 23 aos 49; com exceção de um formando residente em Setúbal, os restantes residem em Lisboa ou arredores. Este grupo conta com 6 médicos, 3 farmacêuticos, uma enfermeira, um fisioterapeuta e um assistente técnico; relativamente aos médicos, a dispersão de anos de experiência é grande, desde profissionais a terminar o internato a profissionais com 15 anos de experiência.

O Plano de Emergência para a Saúde (PES) foi apresentado em maio de 2024 num contexto social, económico, político e histórico particular. Este plano inclui 5 eixos estratégicos que serviram de base para criar 5 equipas na turma, cada uma alocada a um dos eixos estratégicos: 1 Resposta a Tempo e Horas; 2 Bebés e Mães em Segurança; 3 Cuidados Urgentes e Emergentes; 4 Saúde Próxima e Familiar; e 5 Saúde Mental.

A cada equipa foi pedido que escrevesse um *Policy Brief* estruturado com as seguintes secções:

Secção 1: Contextualização do problema

Nesta secção o problema específico do SNS de ficar claramente identificado.

Com base nesta secção, o decisor político deve ter a informação necessária para discutir a situação atual do problema e a sua evolução histórica.

Secção 2: Apresentação sumária das medidas

Nesta secção são apresentadas brevemente as medidas previstas no Plano de Emergência da Saúde e enquadradas no problema previamente contextualizado, clarificando o problema que pretendem resolver.

Secção 3: Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

Esta secção visa analisar o problema identificado na secção anterior segundo a perspetiva da teoria económica e fazer uma análise crítica das medidas propostas com base nesses princípios económicos identificados (análise crítica fundamentada na teoria económica).

Secção 4: Rever ou reforçar as medidas propostas

Esta secção visa abrir a possibilidade de revisão das medidas propostas no PES ou de reforçar a sua justificação; ou ainda para propor outras medidas não contempladas no PES. Esta secção pode ainda conter informação sobre as

barreiras à implementação das medidas, efeitos colaterais não previstos, e benefícios sociais previsíveis.

Os resultados foram meritórios, tendo em consideração o curto espaço de tempo em que foram desenvolvidos. Destaca-se também o empenho e interesse destes profissionais em adquirir novos conhecimentos e em conjugar a sua experiência profissional com os temas discutidos em aula. Foi notável a capacidade de aprendizagem de conceitos abstratos e difíceis de Economia da Saúde e da sua aplicação num contexto complexo como o do sistema de saúde português.

Perspetiva do Plano de Emergência para a Saúde

O Plano de Emergência para a Saúde publicado e iniciado em maio de 2024 assenta em três pilares estratégicos: promoção justa do capital humano, apoio ao doente e investimento em recursos humanos, científicos e tecnológicos. Este plano foi considerado pelo Ministério da Saúde (MS) como uma peça conjuntural no âmbito de uma mudança estrutural da saúde em Portugal. O documento publicado pelo MS não explicita o método adotado na identificação e seleção dos cinco eixos estratégicos, nem fundamenta a escolha dos indicadores de monitorização listados para cada um dos eixos estratégicos, deixando assim antever uma decisão *top-down* (que contribuiu para a intrínseca motivação dos alunos da unidade curricular EPS e vontade de expressar a sua perspetiva).

A monitorização do PES pode ser acompanhada no site do SNS:

<https://www.sns.gov.pt/plano-de-emergencia-e-transformacao-na-saude/>

sendo aqui possível verificar quais as medidas por iniciar, as que estão em curso e as concluídas.

O lançamento do PES veio trazer um vasto conjunto de medidas estratégicas, muitas das quais correspondem a medidas sugeridas anteriormente, e trouxe um debate sobre o SNS mais esclarecido e produtivo.

Dos possíveis contributos do PES, podemos relevar os dois que mais se destacaram nas discussões da unidade curricular de EPS: a imprescindível política de recursos humanos para o SNS assente num só adjetivo “atratividade” e a urgente necessidade de garantia de cobertura universal dos cuidados de saúde prestados pelo SNS:

i) A concentração de um conjunto alargado de medidas num só plano permitiu antever que estas só fazem sentido e só alcançarão o sucesso se houver profissionais de saúde motivados e interessados em ingressar em carreiras atrativas do SNS. Desta forma, o PES veio alavancar a discussão de quais os instrumentos necessários para uma política de recursos humanos em saúde bem-sucedida;

ii) A função última do sistema de saúde e do SNS é garantir uma cobertura universal de cuidados com qualidade e sem o risco financeiro de despesas catastróficas em saúde dos cidadãos. Os últimos anos em Portugal a tendência observada onera a população no acesso aos cuidados e penaliza-os com crescentes necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas. A apresentação do PES veio aclarar publicamente este problema crescente do acesso aos cuidados de saúde e da responsabilidade que o sistema de saúde, e o SNS, têm em garantir a todos esse acesso.

Apesar dos contributos do PES para a melhoria do funcionamento do SNS e do sistema de saúde português, este plano não é incólume a dificuldades e críticas. Tendo em

consideração os resultados das análises dos alunos discutidos no âmbito da unidade curricular de EPS, destacam-se duas dificuldades relativas aos indicadores de monitorização, aos custos/despesas associados às medidas bem como a sua eficiência e eficácia, a seguir descritas:

i) os indicadores de monitorização servem para medir o grau de cumprimento de um critério face a uma referência adotada, sendo um instrumento que visa medir e melhorar ações futuras. Os indicadores apresentados para cada medida são, nalguns casos, dúbios na medida em que apresentam duas componentes de avaliação (por ex., taxa de execução e de cumprimento de prazos), subjetivos (ex., qual o instrumento de medição do indicador satisfação do utente?), incompletos (por ex., qual a referência ou o padrão de comparação adotado para servir de base comparativa ou *gold standard*), ou de natureza diversa (indicadores de procura, indicadores de estrutura, de processo e de resultados¹).

Por outro lado, do ponto de vista económico, a implementação de indicadores de monitorização pode resultar num excessivo foco de cumprimento destes indicadores e no esquecimento de outros indicadores igualmente relevantes, mas que não foram contemplados.

ii) as medidas apresentadas em cada um dos eixos carece de uma estimação do valor monetário associado à sua implementação; nalguns casos poderá haver uma contribuição do PRR mas noutros será o orçamento a financiar. Neste caso, há claramente preocupações de estabilidade orçamental de médio/longo prazo que não pode ser comprometida no âmbito do pacto de estabilidade.

Associada à ausência de quantificação monetária do custo destas medidas do PES, há uma outra incógnita relevante consubstanciada na eficiência destas despesas. O orçamento para a saúde tem sido crescente nos últimos anos, mas os resultados do SNS não têm acompanhado esse aumento de forma proporcional, o que levanta a questão da capacidade de executar e atingir objetivos por parte da administração pública quando realiza despesa em saúde, ou por outras palavras, será que será eficiente a despesa realizada em saúde no âmbito do PES?

Conclusão

Este trabalho realizado em ambiente académico foi um exercício de diálogo entre diferentes profissionais de saúde e académicos, onde se procurou concretizar uma abordagem *bottom-up* na análise de algumas medidas do PES.

Os *Policy Briefs* não têm qualquer pretensão académica, profissional ou política, são unicamente a expressão e visão de profissionais de saúde que diariamente experienciam o sistema de saúde e o SNS português face ao conteúdo do PES adotado pelo Ministério da Saúde.

Com este trabalho visamos tornar pública esta visão e mostrar o interesse e empenho dos nossos alunos em tornarem-se melhores profissionais e em contribuir para um melhor acesso e prestação de cuidados de saúde aos portugueses pelo SNS.

¹Indicadores de Estrutura – indicadores sobre a existência no serviço de uma estrutura adequada a prestar o atendimento ao qual se propõe; Indicadores de Processo – indicadores relacionados com o desenvolvimento do processo assistencial por comparação com um padrão pré-estabelecido. Indicadores de resultado – são indicadores que medem o resultado final da atividade assistencial.

Agradecimentos

Gostaríamos de agradecer a todos os que se empenharam nesta empreitada, em particular aos nossos alunos. Agradecemos o apoio do ISEG Executive Education. Agradecemos também ao Professor Paulo Trigo Pereira e ao IPP – Institute of Public Policy Thomas Jefferson-Correia da Serra – Lisbon pela disponibilidade e apoio na publicação destes *Policy Briefs*.

Aida Isabel Tavares e Eduardo Costa

Eixo Estratégico 1 | Resposta a Tempo e Horas

Filipa Campos Costa

Inês Alegre

Maria Alexandra Cabeleira

Sumário

Eixo Estratégico 1 Resposta a Tempo e Horas	10
1. Contextualização do problema	10
2. Apresentação sumária das medidas	11
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	13
4. Rever ou reforçar as medidas propostas.....	15
5. Considerações finais	17
Referências	19
Anexos	19

1. Contextualização do problema

A Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) e a Lista de Espera para Consulta (LEC) são mecanismos com o objetivo de gerir o acesso dos doentes a estes cuidados de saúde, com base numa identificação eficiente das necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e alocação de recursos, quer sejam públicos, sociais ou privados. No entanto, a elevada quantidade de doentes inscritos nestas listas, bem como o incumprimento frequente dos Tempos Máximos de Resposta Garantida (TMRG), conforme apresentado na tabela 1 em anexo dos dados estatísticos fornecidos pela ACSS [1], são uma preocupação de índole vária. Segundo o Relatório do Tribunal de Contas de 2022 [2], o aumento do número de consultas médicas hospitalares de 3,9% e de cirurgias de 7,7% não foi suficiente para evitar o aumento do número de doentes em LEC de 46% e em LIC de 13%, em relação a 2022 (tabela 2 em anexo). De acordo com os dados disponibilizados em abril de 2024, encontravam-se inscritos na LIC 266624 doentes, dos quais 74463 (cerca de 28%) já tinham ultrapassado o TMRG. No que concerne às LEC, estavam pedidas 891022 consultas, dos quais 454528 (aproximadamente 51%) já tinham excedido o TMRG.

Reconhecendo a necessidade de uma intervenção imediata, foi elaborado um plano estratégico composto por medidas urgentes e prioritárias com o intuito de proporcionar uma resposta rápida aos doentes e medidas estruturais que previnam o agravamento destes indicadores no futuro e possam melhorar o funcionamento estrutural do SNS. Com este propósito, procedeu-se a uma análise detalhada das LIC e LEC, priorizando as necessidades de maior urgência de resolução, considerando tanto o volume de doentes em cada uma destas listas, como o respetivo tempo acima do tempo máximo de resposta

preconizado. Igualmente se reconhece que é necessário melhorar o planeamento dos recursos do SNS e reforçar os mecanismos de controle e avaliação de desempenho, promovendo uma gestão eficaz e a responsabilização de todos os envolvidos.

2. Apresentação sumária das medidas

Das medidas propostas neste eixo, vamos sumariar as três medidas que consideramos mais relevantes: uma medida considerada urgente – A.1 Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024; uma medida prioritária – B.3 Reforço do acesso à consulta especializada; e uma medida estruturante – C.5 Monitorização de acompanhamento à atividade adicional.

Medida A.1 | Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024

A resposta rápida à cirurgia oncológica é de vital importância, considerando a potencial natureza agressiva deste conjunto de patologias. A cirurgia oncológica deve ser realizada sempre que possível de forma célere, uma vez que os atrasos podem resultar na progressão da doença, complicando e/ou diminuindo o sucesso do tratamento.

Segundo a LIC de abril de 2024, cerca de 9374 doentes classificados com patologia oncológica e com necessidade de cirurgia já tinham ultrapassado o TMRG. As especialidades com maior falta de resposta são a Dermatologia, a Urologia e a Cirurgia Geral, sendo a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) a região que apresentava o maior número de doentes em lista de espera.

A medida A.1 visa a maximização da capacidade cirúrgica do SNS e, caso a capacidade deste seja esgotada, a contratualização de cirurgias nos setores social e privado, com o objetivo de tratar todos os doentes oncológicos na LIC que tenham alcançado o TMRG, no prazo de três meses, ou seja, otimizar a capacidade instalada em todo o sistema de saúde.

Para isto, foi definido um cronograma de atividades que inclui:

- Identificação do número de doentes oncológicos inscritos em LIC acima do TMRG,
- Identificação da capacidade instalada do setor público,
- Identificação da capacidade instalada do setor social e privado,
- Definição do modelo de contratualização do setor público, social e privado,
- Definição do modelo operacional e
- Publicação de resultados.

A par deste cronograma, foi selecionada uma lista de indicadores de monitorização de desempenho por forma a controlar e responsabilizar a execução destas medidas, como por ex. a percentagem de complicações pós-operatórias inferior a 10% e a satisfação do doente.

Medida B.3 | Reforço do acesso à consulta especializada

As Listas de Espera para Consulta representam o número de doentes que aguardam por uma consulta médica de especialidade hospitalar, com base na prioridade clínica dos doentes e no Tempo Máximo de Resposta Garantido (TMRG). A gestão eficiente destas listas é essencial para garantir que todos os doentes recebam o atendimento necessário de forma oportuna e eficaz. Em abril de 2024, existiam 891022 doentes na LEC, dos quais 454528 (aproximadamente 51%) já ultrapassaram o TMRG. As especialidades mais carenciadas a nível nacional são a Oftalmologia, que contabiliza 93728 doentes, seguida da Ortopedia (57203) e Dermatologia (38730). A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e a região Norte contabilizam o maior número de consultas por realizar e o Alentejo e a Região LVT são as zonas com o maior tempo médio para consulta.

Plano prevê a identificação das necessidades, uma análise das LECs de cada hospital, o aumento da percentagem de primeiras consultas a tempo e horas nas agendas, o redireccionamento de doentes entre especialidades, uma reavaliação de doentes de prioridade normal, e uma majoração do valor da consulta a tempo e horas acima do TMRG, ou seja, em plano de fundo o propósito último será o de definir um modelo de incentivo aos profissionais de saúde até 31 de dezembro 2024. Por fim, prevê-se a contratualização com o sector social e privado.

A par deste cronograma de implementação da medida foi definida uma lista de indicadores de monitorização que inclui aferição do aumento da percentagem de primeiras consultas vs. consultas subsequentes de 25% para 33% e do controlo da contratualização com o sector social e privado.

Medida C.5 | Monitorização de acompanhamento à atividade adicional

De forma a assegurar que os tempos máximos de resposta são cumpridos, será criada uma nova regulamentação que visa monitorizar, fiscalizar e penalizar as instituições de saúde que não atendam aos objetivos e compromissos propostos, por forma a garantir que os tempos máximos de resposta são cumpridos, e que a prestação de serviços de saúde é feita de uma forma eficaz, eficiente e de qualidade.

Os principais atributos deste regulamento passam por:

- Monitorização contínua: Será identificada uma entidade responsável por monitorizar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantida em todas as instituições de saúde, que avaliará regularmente os indicadores de desempenho,
- Supervisão e fiscalização rigorosa: As instituições de saúde serão submetidas a auditorias regulares para verificar o cumprimento dos prazos e caso sejam identificadas falhas, serão aplicadas sanções,
- Priorização da Patologia Oncológica: Reconhecendo a importância da patologia oncológica e da sua urgência, de acordo com a prioridade clínica respetiva, será dada prioridade a estes doentes de forma que sejam atendidos o mais rápido possível.

3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

Nesta secção iremos tentar discutir os princípios económicos que servem de base às medidas propostas, assim como eventuais repercussões e sua análise crítica. As medidas deste eixo estratégico são apresentadas de forma vaga, nomeadamente não são apresentados os custos previstos associados à implementação de cada uma delas, como serão operacionalizadas, como serão processados os incentivos (monetários ou não monetários), ou quais as bases da contratualização com o setor social ou privado [3].

Medida A.1 | Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024

Esta medida tenta resolver um desequilíbrio entre a oferta e a procura de cuidados de saúde no contexto em que se verifica uma elevada percentagem de pessoas que reporta necessidades de cuidados de saúde não satisfeitas [4]. Sendo o SNS um sistema financiando pelo orçamento de Estado, não há preços para moderar o mercado. Consequentemente, o tempo de espera funciona como moderador da oferta e procura, ou seja, como um mecanismo de racionamento dos cuidados de saúde no mercado [5,6]. Assim, a análise do mercado e da forma como a procura e oferta se comportam face a diferentes estímulos vai depender, não da elasticidade-preço, mas da elasticidade-tempo. Por exemplo, uma oferta muito sensível às variações do tempo de espera, ou seja, muito elástica, então um pequeno aumento da procura não vai ter efeitos significativos no tempo de espera do mercado. Para complementar esta análise microeconómica, é ainda necessário acrescentar que a oferta normalmente está limitada por uma determinada capacidade, o que leva a que num determinado ponto ela passará a ser perfeitamente rígida.

A elevada necessidade de cirurgias oncológicas, reflete uma procura muito pouco elástica, e a capacidade insuficiente do SNS criam uma escassez de serviços de saúde. Ao aumentar a oferta (através da capacidade adicional e do envolvimento do setor social e privado), a medida pretende equilibrar o mercado e reduzir o tempo de espera. De modo a evitar o insucesso da medida (à semelhança do que aconteceu com o programa dos vales-cirúrgicos que teve uma taxa de adesão na ordem dos 4%), é importante que a oferta seja ajustada e considere as necessidades dos utentes. É habitual a recusa por parte dos doentes serem submetidos a cirurgia por um médico que não conhecem ou numa instituição diferente daquela onde são seguidos, como se tem verificado com os vales-cirúrgicos [7].

A priorização de pacientes oncológicos pode ser vista como uma tentativa de melhorar a eficiência distributiva dos recursos de saúde, direcionando-os para onde são mais urgentemente necessários. Em contrapartida, a priorização da doença oncológica poderá levar a uma diminuição da capacidade de resposta às restantes patologias não consideradas prioritárias, o tradicional *trade-off* de alocação de recursos escassos. A implementação desta medida condiciona ainda a decisão dos hospitais sobre a prioridade clínica dos casos (como definir 'prioridade' e quais os critérios?). Além disso, o foco sobre os doentes em lista de espera com TMRG excedidos irá diminuir os recursos para tratar os novos doentes oncológicos que entrem em lista de espera (eventualmente até com necessidades mais urgentes).

A análise de custo-benefício desta medida deve considerar o impacto a longo prazo de tratar pacientes oncológicos de forma oportuna. A medida pode incorrer em custos

elevados ao envolver o setor privado, mas os benefícios de salvar vidas e melhorar os resultados de saúde justificam esses custos. Por último, ao reduzir as listas de espera, esta medida gera efeitos externos (ou externalidades) positivos, como a redução do sofrimento dos doentes e a melhoria da qualidade de vida, com efeitos económicos positivos indiretos.

Medida B.3 | Reforço do acesso à consulta especializada

A aplicação dos princípios da teoria das filas do ramo científico da investigação operacional pode ser uma alternativa para a otimização a gestão das listas de espera, minimizando o tempo de espera e aumentando a satisfação dos pacientes. Neste contexto analisar as taxas de entrada de doentes e a taxa de atendimento dos médicos especialistas pode ajudar a identificar os pontos de constrangimento e a otimizar a alocação de recursos, por ex., aumentar a capacidade de atendimento (contratando mais especialistas) ou redistribuir os pacientes poderá reduzir o tempo de espera. Implementar sistemas/critérios de priorização para consultas especializadas [8] assegura que os casos mais urgentes sejam atendidos primeiro, aumentando a eficiência do sistema e compatibilizando os tempos de espera com as necessidades dos doentes. Assim, utilizar modelos de teoria das filas para simular diferentes cenários e prever o impacto de mudanças na gestão das filas pode ajudar na tomada de decisões baseadas na evidência.

Ao otimizar a gestão das consultas especializadas, o SNS pode aumentar a eficiência produtiva, utilizando melhor os recursos existentes e reduzindo os desperdícios, como consultas duplicadas ou desnecessárias. Ao garantir o acesso equitativo às consultas especializadas, pela abordagem integrada a nível nacional do problema, pode reduzir-se as desigualdades sociais e de saúde, promovendo uma distribuição mais justa dos recursos de saúde.

Medida C.5 | Monitorização de acompanhamento à atividade adicional

A monitorização da atividade adicional visa em última instância fiscalizar e penalizar as unidades de saúde que não cumprem com os compromissos assumidos. Desta maneira, procura-se alinhar os incentivos dos profissionais de saúde e das unidades hospitalares, de forma que o trabalho adicional seja realizado de maneira eficaz e eficiente. Esta medida pode ser enquadrada no âmbito da teoria da agência e dos problemas de agência. Neste contexto os interesses dos diferentes *stakeholders* (profissionais de saúde, gestores hospitalares, unidades hospitalares, sistema de saúde) podem não estar perfeitamente alinhados e a existência de informação assimétrica dificulta que os objetivos sejam atingidos. A monitorização ajuda a alinhar esses interesses recorrendo a incentivos e penalizações. Implementar sistemas de monitorização para atividades adicionais pode reduzir a assimetria de informação, fornecendo aos gestores de saúde e outras chefias hierárquicas uma visão clara das ações dos agentes (profissionais de saúde). O alinhamento de incentivos permite estruturá-los de forma que os interesses dos profissionais de saúde estejam alinhados com os objetivos do SNS. Por exemplo, recompensar atividades que contribuem diretamente para a redução das listas de espera.

Aumentar a transparência e a responsabilidade pode melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços de saúde, assegurando que os recursos são utilizados da melhor forma possível. Estabelecer contratos claros e mecanismos de responsabilização, e a

monitorização das atividades adicionais, contribui para alinhar os incentivos dos profissionais de saúde, garantindo que o trabalho adicional seja realizado de maneira eficaz e eficiente. Além disso, a monitorização da atividade pode identificar oportunidades para economias de escala, onde a expansão de certas atividades pode reduzir o custo médio de prestação de serviços de saúde.

4. Rever ou reforçar as medidas propostas

Da análise global do eixo 1, merecem o nosso destaque os seguintes aspetos:

O documento foca-se no tratamento dos doentes acima do TMRG. Ora, sendo este TMRG uma determinação meramente política e estanque, que pode não traduzir a real prioridade clínica (como definir 'prioridade?'), este documento, parece-nos, ter um objetivo mais de natureza organizacional e do que clínica. O foco não devem ser apenas os doentes acima do TMRG, mas sim todos os doentes oncológicos.

Embora este plano estratégico inclua medidas estruturantes de efeito de médio longo-prazo, é claro que a preferência do MS é uma resposta de curto-prazo e imediata, focando-se em resolver o problema agudo das listas de espera. A origem do problema do Sistema de Saúde Português é descurada em todo o documento, não sendo feita qualquer referência àquilo que consideramos ser efetivamente importante e transformador. É necessário analisar e aprofundar o entendimento sobre qual a origem das listas de espera no SNS, será uma real escassez de recursos ou apenas uma má gestão destes?

Se não se trabalhar de forma re/estruturante na eficiência dos recursos existentes, como a utilização dos blocos operatórios e das equipas de cirurgia, iremos estar sempre a gastar recursos em medidas remediadoras.

O conjunto destas medidas visa, primariamente, aumentar a produção e prestação de serviços pelo SNS (mais cirurgias oncológicas, mais consultas de especialidade) sem aumentar os recursos, o que pode resultar numa perda de qualidade do serviço prestado. A evidência empírica [9] mostra que o aumento da produção, utilizando os mesmos recursos, tem efeitos negativos sobre a qualidade dos serviços de saúde

Salientamos por último, e recorrendo à Lei de Goodhart [10], que este conjunto de medidas pode ter um efeito perverso: quando o regulador coloca o foco numa medida (no caso o tempo de espera), esta medida deixa de ser fiável porque se torna uma meta e os agentes tentarão falseá-la. No nosso caso, como os hospitais sabem que estão a ser monitorizados, poderão encontrar estratégias para tentar não ser penalizados, sem cumprir o verdadeiro objetivo de tratar os doentes (o problema da relação de agência). A título de exemplo, aquando da realização de uma proposta cirurgia se o doente não for rotulado de “oncológico”, os períodos de espera para cirurgia são automaticamente alargados, evitando que os hospitais sofram pressão ou penalização por terem listas de espera de doentes oncológicos acima dos tempos previstos.

Medida A.1 | Regularização da lista de espera para cirurgia oncológica: OncoStop2024

As possíveis barreiras à implementação desta medida que consideramos mais substâncias e prováveis são as seguintes:

- A coordenação entre diferentes hospitais públicos, sociais e privados pode enfrentar desafios logísticos, tais como a transferência de pacientes e respetiva informação e a interoperabilidade dos sistemas de tecnologia de informação. A informação do hospital de origem nem sempre está disponível no SPMS, além de que no âmbito da transferência da informação não está definido, quem determina a informação é transmitida e nem a quem se destina.
- Os profissionais de saúde podem dar resposta a um aumento, mesmo que temporário, da carga de trabalho, mesmo com incentivos financeiros; no entanto, o risco de *burnout* é prevalente, mesmo quando o incremento de trabalho passa a ser definitivo. É premente a avaliação da necessidade de profissionais no SNS que são necessários para dar uma resposta correspondente à procura refletida nas listas de espera.
- O aumento da carga de trabalho não recai apenas nos profissionais diretamente envolvidos nas cirurgias, mas também para outras áreas envolvidas indiretamente no tratamento destes doentes que não conseguem habitualmente dar resposta e são excluídas dos incentivos. Ou seja, aquando da realização de uma cirurgia oncológica existem múltiplos profissionais envolvidos para os quais não está preconizado qualquer incentivo, como por exemplo, os anatomo-patologistas, os intensivistas, os radiologistas, os administrativos, os enfermeiros dos serviços de internamento.
- A imprecisão dos dados do SNS e a sua constante atualização é outra das dificuldades permanentes do sistema. Por exemplo, o número de doentes inscritos em LIC que servem por base à execução deste plano estratégico foi, entretanto, revisto e está desatualizado. A aplicação de medidas ou a criação de um plano estratégico sem ter dados atualizados de forma estrita torna todo o plano não fundamentado e a pertinência das medidas questionável. A obtenção de dados corretos deveria ter sido feita *a priori* para compreender a real dimensão do problema e aplicar medidas ajustadas.

Consideramos possíveis efeitos colaterais e externalidades:

- O foco em cirurgias oncológicas e consultas especializadas pode desviar recursos de outras áreas igualmente críticas, causando desequilíbrios no sistema de saúde.

Múltiplos doentes em listas de espera não oncológica apresentam também patologias graves e com necessidade de intervenção urgente precoce. Na mesma linha de pensamento todos os doentes oncológicos entretanto inscritos em lista de espera também ficarão à espera, enquanto os hospitais colocam o seu foco e esforço no combate às listas de espera referentes a Abril 2024.

- A pressão para reduzir as listas de espera rapidamente pode levar a uma redução da qualidade dos cuidados prestados, como já foi referido. Além disso, assumir uma taxa máxima de complicações de cirurgia de 10%, podem dar incentivos perversos aos hospitais para aplicar os recursos nas cirurgias mais simples (potencialmente com menor probabilidade de complicações) que podem não ser as mais prioritárias.

Medida B.3 | Reforço do acesso à consulta especializada

Consideramos possíveis barreiras à implementação desta medida a escassez de recursos humanos, que é, aliás, um problema transversal a todo o PES. Por outro lado, a

infraestrutura existente pode não suportar o aumento do número de consultas, necessitando de investimento em instalações e equipamentos. A falta de espaço físico (gabinetes de consulta) nas instituições hospitalares é efetiva e habitual.

Os possíveis efeitos colaterais e externos incluem a dificuldade de definir incentivos que funcionam de forma correta. O incentivo à realização de primeiras consultas é por si só um desincentivo à realização de consultas subsequentes, igualmente importantes para os doentes. A maioria dos doentes seguidos em consultas no SNS são seguidos por necessidade. Ao fiscalizar e penalizar instituições de saúde por violação dos tempos de resposta, promove-se um acompanhamento mais curto do doente podendo ser prejudicial para o mesmo. Incentivar as altas de forma a dar espaço para primeiras consultas pode afetar a qualidade dos serviços prestados.

Por fim, a nossa proposta de três medidas complementares:

- Ampliação do uso da telemedicina para consultas de acompanhamento e gestão de doenças crónicas, o que pode aliviar a pressão sobre as consultas especializadas presenciais.
- Implementação de programas robustos de prevenção e educação em saúde para reduzir a incidência de doenças crónicas e oncológicas a longo prazo.
- Aferição da indicação efetiva para consultas de especialidade hospitalar. Na prática clínica, são muitas vezes identificadas referenciações de doentes pelos Cuidados de Saúde Primários por motivos “pouco válidos”, o que cria uma sobrecarga nas consultas, com consequente diminuição da capacidade de resposta global. Esta falsa necessidade de referenciação para consultas de especialidade hospitalar prende-se também em alguns casos com a pressão sobre a prescrição realizada pelos médicos dos Cuidados de Saúde Primários, nomeadamente pelas limitações na requisição de exames complementares de diagnóstico.

Medida C.5 | Monitorização de acompanhamento à atividade adicional

As possíveis barreiras à implementação desta medida que pensamos que podem ser levantadas são as seguintes:

A implementação um sistema eficaz de monitorização pode ser tecnicamente desafiador e caro, especialmente se envolver a integração de múltiplos sistemas de informação de saúde. A colheita e monitorização de dados adicionais individuais levantam preocupações sobre a privacidade e segurança dos dados dos utentes.

Os profissionais de saúde podem ver a monitorização como uma intrusão, afetando a sua aceitação e adesão à medida. É o dever deontológico dos médicos que limita a perversão dos incentivos propostos.

5. Considerações finais

Reduzir as listas de espera para cirurgias oncológicas e consultas especializadas melhora significativamente os resultados de saúde, reduzindo a mortalidade e a morbilidade. Além disso, a implementação das medidas propostas pode reduzir desigualdades no acesso

aos cuidados de saúde, beneficiando especialmente as populações vulneráveis. Acreditamos que a eficiência e a capacidade de resposta do SNS podem ser aprimoradas e que a redução dos tempos de espera e a melhoria da qualidade dos cuidados podem aumentar a satisfação dos utentes e a confiança no SNS.

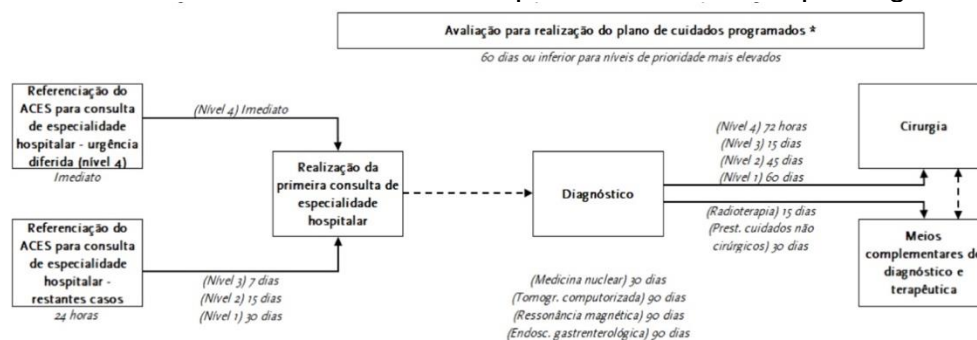
Reforçamos a necessidade de estabelecer um sistema contínuo de monitorização e de avaliação de todo o sistema para ajustar as estratégias conforme necessário e garantir a eficácia das medidas implementadas.

Referências

1. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). (2024). Administração Central do Sistema de Saúde, IP . <https://www.acss.min-saude.pt/>
2. Tribunal de Contas. (2022). Auditoria ao acesso a cuidados de saúde oncológicos no SNS 2017-2020 (Relatório 11/2022, 2ª secção).
3. Siciliani, L., Borowitz, M., & Moran, V. (2013). Waiting time policies in the health sector: What works? OECD Health Policy Studies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264179080-en>
4. Eurostat. (2024). Unmet health care needs statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unmet_health_care_needs_statistics
5. Lindsay, C. M., & Feigenbaum, B. (1984). Rationing by waiting lists. American Economic Review, 74 (3), 404–417.
6. Martin, S., & Smith, P. C. (1999). Rationing by waiting lists: An empirical investigation. Journal of Public Economics, 71 , 141–164.
7. Cruz, S., Quintal, C., & Antunes, P. (2022). Risk factors associated with the refusal of surgery vouchers: The case of Central Portugal. Acta Medica Portuguesa, 35 (3), 201–208.
8. CHE Policy Forum. (n.d.). Living with long waiting times: Approaches to prioritising [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=X-AxY54-P2Y>
9. Grieco, P., & McDevitt, R. C. (2017). Productivity and quality in health care: Evidence from the dialysis industry. Review of Economic Studies, 84 (3), 1071–1105.
10. Chrystal, K. A., & Mizen, P. D. (2001). Goodhart's law: Its origins, meaning and implications for monetary policy . https://cyberlibris.typepad.com/blog/files/Goodharts_Law.pdf

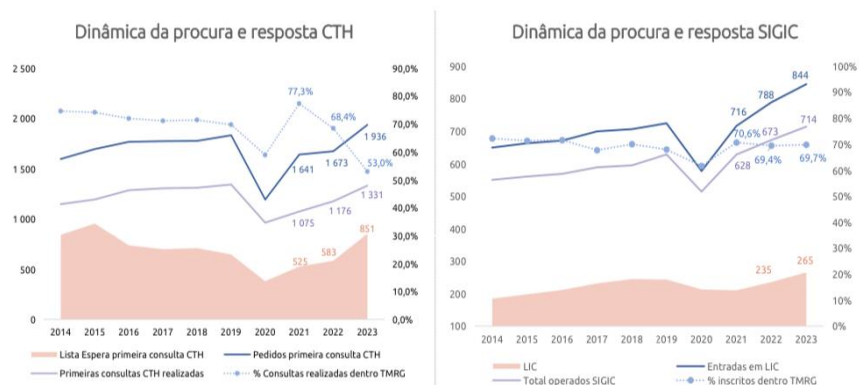
Anexos

Tabela 1 – Circuito dos doentes no SNS e tempos máximos de resposta garantidos.



Fonte: Tribunal de Contas (2022) [2].

Tabela 2 – Acesso programado a consultas hospitalares e a cirurgias (valores em milhares, salvo indicação em contrário)



Fonte: ACSS. | Notas: CTH – Programa Consulta a Tempo e Horas; TMRG – Tempos Máximos de Resposta Garantidos; LIC – Lista de Inscritos para Cirurgia; SIGIC - Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia.

Fonte: ACSS(2024) [1].

Eixo estratégico 2 | Bebés e Mães em Segurança

Bárbara Ferreira

Filipa Gonçalves

Margarida Canelas

Sumário

Eixo estratégico 2 Bebés e Mães em Segurança	21
1. Contextualização do problema	21
2. Apresentação sumária das medidas	23
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	24
4. Rever ou reforçar as medidas propostas.....	27
Referências	29

1. Contextualização do problema

A segurança materna na saúde é de extrema importância para garantir a saúde e bem-estar das mães durante a gravidez, parto e pós-parto. Ao promover a segurança materna, é possível reduzir complicações obstétricas e neonatais, mortalidade materna e garantir um ambiente seguro para a mãe e bebé. Desta forma, a segurança materna está diretamente relacionada com a prevenção de doenças e cuidados pós-parto, contribuindo para uma recuperação mais tranquila e saudável da mãe, bem como com a prevenção de comorbilidades neonatais.

Entre os principais desafios e riscos relacionados com a segurança materna na saúde, destacam-se a falta de acesso a cuidados pré-natais adequados, o atraso na identificação de complicações durante a gravidez e o parto, e ainda a falta de suporte pós-parto para as mães. Assim, as disparidades no acesso aos serviços de saúde (obstetrícia, planeamento familiar e saúde materno-infantil) e a falta de informação adequada sobre a importância da segurança materna também representam desafios significativos.

As políticas e estratégias recomendadas para garantir a segurança de bebés e mães na saúde incluem a implementação de programas de vigilância pré-natal abrangentes, acesso equitativo a cuidados de saúde de qualidade, incentivo ao parto humanizado e investimento em profissionais de saúde capacitados. Além disso, a promoção da amamentação e a consciencialização sobre os direitos reprodutivos das mulheres são fundamentais para a segurança materna e infantil.

As principais mensagens do presente documento enfatizam a importância da segurança materna e do bebé na saúde, destacando os principais desafios e riscos enfrentados. Adicionalmente, ressalta a necessidade de políticas eficazes, intervenções integradas e boas práticas para garantir a segurança e o bem-estar das mães e bebés. É essencial

reforçar a importância da capacitação de profissionais, do *continuum* da educação para grávidas e do acesso equitativo a serviços de qualidade como elementos fundamentais para a promoção da segurança materno-infantil.

Atualmente, no panorama nacional podemos encontrar 41 maternidades; 28 maternidades em funcionamento ininterrupto; 2 maternidades em funcionamento por referenciação; 8 maternidades encerradas; e ainda 5 maternidades do setor privado.

Porque encerram as maternidades?

Porque as equipas de urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos têm um requisito mínimo exigido de clínicos especialistas presentes para poderem funcionar. O número mínimo de clínicos, quer médicos especialistas em Ginecologia-Obstetrícia e enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica é definido de acordo com o volume de produção, ou seja, o número de partos/ano de cada instituição. O atendimento urgente tem encerrado quando não se verifica o cumprimento daquele requisito traduzido no número mínimo de profissionais clínicos. Este encerramento ou condicionamento dos serviços de Urgência por falta de médicos é um problema transversal ao país e não é um fenómeno novo, ocorrendo, sobretudo, nos períodos de férias.

Os hospitais que encerrem as urgências de Ginecologia e Obstetrícia devem comunicar a decisão ao Instituto Nacional de Emergência Médica, pelo que os doentes urgentes transportados por ambulância devem ser encaminhados para outras unidades de saúde, de acordo com as diretrizes do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). No entanto, nem sempre esta informação chega ao público, resultando numa extrema dificuldade aos utentes que se deslocam por meios próprios à urgência e esta não está a funcionar.

Em junho de 2022 foi implementado um “plano de contingência” previsto como solução de curto prazo, para responder à falta de profissionais nos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia. Contudo, em 2024 a problemática mantém-se e o Ministério da Saúde necessitou de elaborar um Plano de Emergência da Saúde (PES), publicado em maio de 2024, que incluí um eixo dedicado à esta problemática.

A desigualdade no acesso à saúde constitui uma injustiça social e civilizacional que importa ser combatida. Desta forma, o PES visa a implementação de medidas urgentes e prioritárias que garantam o acesso a cuidados de saúde ajustados às necessidades efetivas da população. Por isso, ambiciona-se que as medidas desenvolvidas se apresentem como soluções que permitam rentabilizar e otimizar a resposta do SNS.

O eixo e do PES está relacionado com a Saúde Materno-Infantil e tem como objetivo geral assegurar o acesso das utentes grávidas aos cuidados de saúde, garantindo a segurança clínica no contexto da saúde materno-infantil, com vista a:

- Otimizar a capacidade da rede de maternidades e o acesso da grávida aos cuidados de saúde;
- Reforçar os mecanismos de comunicação entre a grávida e o SNS;
- Potenciar as valências dos profissionais de saúde envolvidos no acompanhamento da grávida e no parto.

Pretende-se, assim, garantir que todas as grávidas tenham acesso a cuidados de saúde materno-infantil em tempo útil, com a máxima segurança e qualidade, proporcionando assim um ambiente seguro e acolhedor para o nascimento de novas vidas.

2. Apresentação sumária das medidas

As medidas apresentadas no PES organizam-se em três níveis de prioridade:

- Medidas urgentes – resultados até 3 meses
- Medidas prioritárias – resultados até ao final de 2024
- Medidas estruturantes - resultados nos próximos 2 anos.

Na tabela 1 apresenta-se a síntese das medidas por prioridade, objetivo e problema que visam resolver.

Tabela 1: Descrição das medidas

Medidas	Objetivo	Problema a resolver
Urgente		
Criação de canal de atendimento direto para a grávida, alavancando na linha SNS 24 (SNS Grávida)	Privilegiar/facilitar comunicação Organizar circuitos	Acesso limitado aos serviços de Urgência Obstétrica, em virtude do encerramento permanente ou pontual de alguns serviços
Atribuição de incentivos financeiros para aumentar a capacidade de realização de partos	Rentabilizar capacidade instalada das maternidades	Limitação de vagas, tendo em conta o aumento do volume de produção
Reforço de convenções com o setor social e privado		
Prioritária		
Criação de um regime de Atendimento Referenciado de Ginecologia de Urgência	Alocar adequadamente os recursos humanos	Acesso limitado aos serviços de Urgência Obstétrica, em virtude do encerramento permanente ou pontual de alguns serviços
Atualização dos rácios de pessoal e da composição das equipas nos locais de parto em função de critérios técnico-científicos atendíveis	Otimizar recursos e rentabilizar a capacidade de intervenção (valências técnico-científicas)	Adequação de recursos humanos, tendo em conta a valência
Revisão da tabela de preços convencionados para Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (ecografias pré-natais)	Promover o rastreio pré-natal adequado	Acesso a vigilância pré-natal de acordo com as normas da DGS para a adequada vigilância de saúde materna
Generalização do Atendimento Pediátrico Referenciado	Alargar o acesso a cuidados agudos e urgentes no contexto das ULS	Acesso limitado aos serviços de Urgência Pediátrica, em virtude do encerramento permanente ou pontual de alguns serviços
Estruturante		

Separação das especialidades de Ginecologia e Obstetrícia	Alocar adequadamente os recursos humanos	Adequação de recursos humanos, tendo em conta a valência
Reforço do acompanhamento da grávida por Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia	Potenciar o papel dos Enfermeiros Especialistas em Saúde Materna e Obstetrícia (EESMO)	Dificuldade de acesso a consultas de vigilância de saúde materna, em gravidez de baixo risco
Estabelecimento de novas estruturas organizacionais para blocos de parto / obstetrícia	Promover a diferenciação, autonomia e capacidade dos Blocos de Partos	Limitação de vagas, tendo em conta o aumento do volume de produção

3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

A população tem necessidades ilimitadas que não podem ser satisfeitas na sua totalidade porque os recursos são escassos, como descreve um dos pressupostos de base da ciência económica. Desta forma, torna-se necessário realizar escolhas sustentadas e fundamentadas, obrigando a *trade-offs* difíceis de alocação de recursos. No setor da saúde, este aspeto é particularmente relevante, o que poderá justificar a aplicação de teorias económicas aos problemas associados à saúde para que se possa procurar decisões eficientes e otimizar os recursos disponíveis [1].

Em suma, a análise económica em saúde é uma ferramenta crucial para avaliar a eficiência e o impacto económico das intervenções nesta área [2]. Esta análise visa identificar e mensurar os custos e benefícios das diferentes opções de tratamento, prevenção e promoção da saúde [3], fornecendo informações essenciais para a tomada de decisão em políticas públicas e gestão de recursos. A análise económica em saúde contribui também para a alocação eficiente de recursos, promovendo a equidade no acesso aos serviços e a melhoria da qualidade e segurança do sistema de saúde.

A.1 | Criação de canal de atendimento direto para a grávida, alavancando na linha SNS 24 (SNS Grávida)

Uma das medidas descritas como urgente e já implementada, com avaliação de resultados demonstrada, foi a criação da Linha SNS Grávida. Esta medida materializa um instrumento de melhoria da correspondência entre a oferta e a procura. Num balanço feito no primeiro mês de funcionamento desta linha de saúde, podemos destacar alguns números:

- Das 277 mil chamadas atendidas pelo SNS24, 8260 foram de utentes grávidas (3%);

- Mais de 870 grávidas (cerca de 11% das utentes triadas) evitaram deslocação a um SU, sendo que 470 destas utentes tinham intenção prévia a esta triagem, de se dirigir a um serviço de urgência;

- 17% das utentes foram encaminhadas para uma unidade de Cuidados de Saúde Primários;

- 5866 utente foram encaminhadas para um SU (cerca de 70% das chamadas recebidas).

Considerando estas informações quantitativas, podemos concluir que foi possível uma melhor alocação dos recursos do SNS, visto que foram evitadas mais de 870 deslocações ao serviço de urgência pela triagem realizada na nova linha SNS Grávida, para além de uma mitigação da incerteza habitualmente associada ao mercado da saúde e dos cuidados de saúde.

De acordo com o relatório da Evolução do Desempenho do SNS em 2023 do Conselho de Finanças Públicas [4], poder-se-á concluir que a atividade hospitalar do SNS aumentou, mas de forma insuficiente para satisfazer a procura. Nos episódios de urgência, o cumprimento dos tempos de triagem apenas aconteceu em 60% dos casos (61% em 2022); foi também verificado que a despesa do SNS aumentou 6,8% relativamente a 2022, com acréscimo de 761,8M€ relativos a despesas correntes. Considerando que dois terços da despesa corrente são as despesas de compras e despesas com pessoal, ao reduzirmos a afluência ao serviço de urgência, serão reduzidas estas duas componentes significativas de despesa no SNS.

B.2 | Atualização dos rácios de pessoal e da composição das equipas nos locais de parto em função de critérios técnico-científicos atendíveis

No que respeita à medida prioritária sobre a atualização dos rácios de pessoal e da composição das equipas nos locais de parto em função de critérios técnico-científicos atendíveis, o objetivo será otimizar as valências das equipas multidisciplinares nos locais de parto, de forma a garantir a disponibilidade das mesmas e rentabilizar a sua capacidade diária de acordo com a procura e recursos disponíveis.

Nos locais de parto, a equipa multidisciplinar permite assegurar os cuidados de saúde no processo de trabalho de parto. As competências do Especialistas de Enfermagem Materna e Obstétrica (EESMO), como parte integrante dessas equipas está bem definida e, de acordo com a Orientação nº2/2023 de 10/05/2023, atualizada a 26/03/2024 pela DGS (2023) [5], o internamento hospitalar de uma grávida em trabalho de parto considerado de baixo risco pode ser realizado por um profissional EESMO. Quando a grávida observada não cumpre os critérios de trabalho de parto de baixo risco, terá de ser observada por um Médico especialista em Ginecologia/Obstetrícia.

A criação de equipas multidisciplinares é analisada pela ciência económica recorrendo a funções de produção com diferentes inputs, ou seja, com diferentes profissionais que geram diferentes *skill-mix* [1,6]. A constituição destas equipas pode ser versátil e flexível uma vez que é possível obter o mesmo nível de *output*, os partos, com diferentes *skill-mix*. O desafio económico é a determinação das equipas ótimas que permitem minimizar os custos e maximizar os *outputs* numa determinada unidade de saúde.

Na evolução do desempenho do SNS em 2023 [4], na atividade hospitalar, o número de consultas médicas hospitalares aumentou face a 2022 (em 3.9%), o que não foi suficiente para evitar o aumento considerável do número de utentes em lista de espera para a primeira consulta em 2023 (em 46% face ao ano anterior). No que diz respeito à atividade dos Blocos de Partos, Portugal registou 85764 nascimentos em 2023, mais 2328 do que no ano anterior.

Desta forma, e a título de exemplo, das 10 maternidades localizadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, apenas 3 têm em vigor o protocolo de internamento de grávidas de baixo

risco que apresentam rotura espontânea da bolsa ou que se encontrem em fase ativa de trabalho de parto. A implementação deste protocolo nas restantes maternidades permitirá uma gestão mais eficaz dos recursos nos serviços de urgência obstétrica, uma vez que o processo de internamento se torna mais célere e as equipas médicas poder-se-ão dedicar a situações de maior urgência/emergência, ou que careçam de maior diferenciação clínica. Ou seja, esta realocação de recursos baseada num protocolo clínico permite que com os mesmos recursos disponíveis seja possível atingir um nível de produção mais elevado, representando uma melhoria de eficiência do sistema.

A presente medida converge com a medida de reforço do acompanhamento da grávida por Especialistas em Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia uma vez que, à semelhança do que acontece no serviço de urgência, os profissionais EESMO apresentam diferenciação clínica que os capacita para a realização da vigilância pré-natal de grávida de baixo risco. Esta condição faz com que seja possível garantir a vigilância de um maior número de grávidas, garantindo os *timings* designados a cada um dos trimestres da gravidez.

C.3 | Estabelecimento de novas estruturas organizacionais para blocos de parto/obstetrícia

A evolução histórica das estruturas organizacionais em blocos de partos é marcada por mudanças significativas ao longo do tempo, refletindo avanços na tecnologia, na prática clínica e nas expectativas das grávidas. Desde modelos tradicionais até estruturas mais modernas, houve uma busca constante por melhorias na eficiência, segurança e qualidade do cuidado obstétrico. Compreender essa evolução é essencial para contextualizar as discussões atuais sobre inovações em unidades de bloco de partos.

As tendências atuais em estruturas organizacionais para unidades de bloco de partos estão voltadas para a promoção de práticas centradas na mulher, respeitando sua autonomia, preferências e cultura. Além disso, a integração de equipas multidisciplinares, a utilização de abordagens baseadas em evidências e a implementação de tecnologias para otimizar o cuidado obstétrico representam algumas das necessidades emergentes nesse contexto, visando melhores resultados para mães e recém-nascidos.

O avanço tecnológico tem desempenhado um papel crucial na melhoria dos serviços prestados nos blocos de partos, permitindo o desenvolvimento de estruturas organizacionais mais eficientes e seguras. A implementação de tecnologias inovadoras tem proporcionado aprimoramentos significativos no cuidado à grávida e ao recém-nascido, impactando positivamente a qualidade dos serviços prestados.

Do ponto de vista económico, o benefício em qualidade de vida e de saúde a médio/longo prazo superam os custos (o rácio benefício-custo é superior à unidade) [3], uma vez que se verificará melhoria na eficiência operacional, mitigação de riscos, maior satisfação dos profissionais e utentes, e melhorias da qualidade no cuidado prestado. Além disso, a implementação de práticas baseadas em evidência e a integração de tecnologias podem impactar positivamente nos *outcomes* clínicos.

4. Rever ou reforçar as medidas propostas

Nesta secção pretende-se esboçar comentários e discussão adicionais a algumas medidas acima apresentadas. Na tabela 2 foi sumariada a análise crítica ou de justificação associada a cada uma das medidas selecionadas sobretudo ao nível da aplicabilidade, efetividade e robustez.

Tabela 2: Análise crítica de algumas medidas

Medidas	Análise crítica
Urgente	
A.2 Atribuição de incentivos financeiros para aumentar a capacidade de realização de partos	Esta medida, ainda que necessária e viável, relaciona-se mais com a valorização e retenção de talentos no SNS, do que com a rentabilização da capacidade instalada para a realização de partos. A escolha de uma maternidade pela grávida é influenciada por inúmeros fatores, sendo que os incentivos aos profissionais podem não ter impacto nessa escolha.
A.3 Reforço de convenções com o setor social e privado	Medida já implementada desde 2020. A implementação desta medida será sempre influenciada pelo volume de produção do setor privado, devendo ser tida em linha de conta a qualidade e segurança dos cuidados às grávidas.
Prioritária	
B.1 Criação de um regime de Atendimento Referenciado de Ginecologia de Urgência	Medida que, a ser implementada, pode verificar-se bastante eficaz uma vez que, atualmente, dos 43 serviços de urgência existentes, apenas 2 são exclusivos da especialidade de Ginecologia. A criação de um regime de atendimento referenciado de Ginecologia permitirá o alívio do volume de episódios de urgência, dado que 40% dos episódios de urgência atendidos por médicos especialistas em Ginecologia/Obstetrícia dizem respeito a casos ginecológicos não urgentes.
B.3 Revisão da tabela de preços convencionados para Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (em particular, ecografias pré-natais)	A realização atempada das 3 ecografias previstas durante a vigilância da gravidez é crucial. Atualmente, a capacidade instalada para realização de ecografias através do SNS mostra-se limitada e pode não ter capacidade de resposta. A implementação desta medida parece consistente, na medida em que permitirá alargar o leque de recursos para realização das ecografias.
B.4 Generalização do Atendimento Pediátrico Referenciado	Esta medida, a par com outra medida acima analisada, poderá ter um impacto positivo no volume de episódios de urgência pediátrica, canalizando os doentes pediátricos pouco urgentes e não urgentes para outros pontos de atendimento.
Estruturante	
C.1 Separação das especialidades de Ginecologia e Obstetrícia	Dentro da especialidade de Ginecologia/Obstetrícia, os clínicos subespecializam-se em áreas específicas. Tendo em conta a escassez de recursos humanos e a sua possibilidade de mobilidade (dentro de um raio de distância viável, para equilíbrio da vida profissional e familiar), a gestão e alocação destes recursos pode ser revista, garantindo as dotações mínimas de especialistas em obstetrícia nas maternidades. Esta medida dependerá das contingências e disponibilidade dos profissionais de cada organização. Contudo, e agregando à medida dos incentivos financeiros, poderá ser uma medida com efetividade para garantir a alocação correta e necessária de recursos.

Em suma, considerando o custo-benefício da implementação da maioria destas medidas, tendo em conta os custos diretos e indiretos, impacto social e impacto económico, possivelmente revelará um rácio benefício-custo superior à unidade (trabalhos futuros de avaliação económica poderão confirmar, ou não, a nossa proposta).

Proposta de medida adicional

Criação de “Casas de Parto”, à semelhança de outros países da Europa, que se trata de estabelecimentos especializados em prestar assistência ao parto normal de baixo risco, fora do ambiente hospitalar tradicional. Estes estabelecimentos configuram uma

alternativa aos hospitais, oferecendo um ambiente mais acolhedor e menos medicalizado para as mulheres que desejam um parto natural, com o mínimo de intervenção por parte das equipes clínicas.

A história das casas de parto [7] remonta a práticas tradicionais de assistência ao parto, onde as mulheres eram atendidas por parteiras em ambientes acolhedores e familiares. Essas práticas evoluíram ao longo do tempo, com a influência da medicina moderna e as mudanças nas políticas de saúde. As casas de parto surgiram como uma alternativa ao modelo hospitalar, buscando resgatar a humanização do parto e valorizar a autonomia da mulher durante o processo de gestação e nascimento.

Estudos indicam que casas de parto estão associadas a taxas reduzidas de cesarianas, episiotomias e uso de medicamentos para alívio da dor, promovendo uma recuperação materna mais rápida. Além disso, o contato pele a pele imediato entre mãe e bebê e a promoção do aleitamento materno exclusivo são práticas comuns que contribuem para a saúde neonatal [8]. No entanto, é fundamental garantir que as casas de parto atendam os requisitos de segurança e qualidade para assegurar um impacto positivo na saúde materna e neonatal.

Devem, por isso, localizar-se num raio próximo ao hospital de referência e dispor de uma ambulância com equipamento de suporte pediátrico, visando uma estrutura consistente para transferência rápida ao hospital em caso de complicações.

A legislação e regulamentação das casas de parto variam amplamente entre os países, influenciadas pela cultura, tradições e sistemas de saúde locais. Alguns países têm leis específicas que regem a operação e prestação de serviços em casas de parto, enquanto outros ainda estão em processo de desenvolvimento de políticas nesse sentido. É importante considerar as diferenças legais e regulatórias ao avaliar e comparar as casas de parto à escala internacional, para entender melhor os desafios e oportunidades enfrentados em cada contexto.

Sendo assim, mediante contexto económico, as casas de parto evitam a utilização de muitos recursos, evitando, portanto, o aumento da despesa do SNS, já que lidam com partos de baixo risco e não se colocam questões de intervenções, da necessidade de recorrer a medicação, e da necessidade de realização de exames específicos. Assim, as casas de parto permitem um alívio sobre a pressão de recursos hospitalares, permitindo que estes se foquem em casos mais urgentes e críticos, possível redução de custos com infraestrutura, uma utilização eficiente de recursos e, como já identificado, uma provável redução de complicações no pós-parto.

Siglas e abreviaturas

CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes

PES - Plano de Emergência da Saúde

SNS – Serviço Nacional de Saúde

Referências

1. Giraldes, M. R. (1997). Economia da saúde da teoria à prática (1ª ed.). Editorial Estampa, Imprensa Universitária.
2. Campos, A. C. (1986). Avaliação económica de programas de saúde (Cadernos de Saúde 10). Escola Nacional de Saúde Pública.
3. Alves, A. D. (1991). Análise custo-benefício do Novo H. D. Guimarães. Gestão Hospitalar, 20 , 24–32.
4. Conselho de Finanças Públicas (CFP). (2024). Desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023 (Relatório 07/2024). Lisboa.
5. Direção Geral da Saúde (DGS). (2023). Normas e circulares normativas . <https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas.aspx>
6. Kernick, D., & Scott, A. (2002). Economic approaches to doctor/nurse skill mix: Problems, pitfalls, and partial solutions. The British Journal of General Practice: The Journal of the Royal College of General Practitioners, 52 (474), 42–46.
7. Hoga, L. A. K. (2004). Casa de parto: Simbologia e princípios assistenciais. Revista Brasileira de Enfermagem, 57 (5), 537–540.
8. Graça, L. M. (2017). Medicina materno-fetal (5ª ed.). Lidel. ISBN: 9789897522888.

Eixo estratégico 3 | Cuidados Urgentes e Emergentes

Fábio Pereira

João Coucelo

Ricardo Dias

Sumário

Eixo estratégico 3 Cuidados Urgentes e Emergentes.....	30
1. Contextualização do problema	30
2. Apresentação Sumária das Medidas	31
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	32
4. Rever ou reforçar as medidas propostas.....	34
Referências	39

1. Contextualização do problema

O plano emergência para saúde (PES), em particular para a área da Urgência e Emergência, foi desenvolvido para responder à falência dos Serviços de Urgência (SU) [1]. Este plano surge quando apesar de o número total de episódios de urgência geral, pediátricos e psiquiátricos, não ter registado um aumento [2] e o número de horas contratadas de prestação de serviços médicos ter aumentado [3]. Esta falência dos SU poder-se-á traduzir de duas formas: na necessidade de encerrar SU em diferentes pontos [4], e/ou no aumento dos tempos para observação após a triagem e nos tempos de permanência dos doentes nos SU [5].

No contexto atual existe uma ideia geral de que os Cuidados de Saúde Primários (CSP) deveriam dar uma maior resposta a pessoas com doença crónica, aguda não urgente e pouco urgente. Contudo, a carência crescente de médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar (MGF) nos CSP tem resultado num aumento de pessoas sem médico de família (1,7 milhões em 2023) [6] e numa crescente dificuldade dos CSP em dar resposta à sua missão e desígnios base. Reconhece-se ainda a necessidade de investir nos hospitais de dia das diferentes patologias crónicas e com um maior número de agudizações (p.ex.: a insuficiência cardíaca, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e oncológica). Porém, esta necessidade também tem esbarrado na falta de médicos de diferentes especialidades no SNS. Assim, muitos destes doentes acabam por recorrer aos SU para verem atendidos os seus problemas de saúde. As estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) são uma fonte significativa de casos para os SU, quer seja por situações que não são resolvidas nas próprias, por falta de apoio médico, quer seja pela organização destas, e por impedimentos legais para administração de determinadas terapêuticas.

No que se refere ao circuito do doente no SU, há problemas desde as estruturas físicas desadequadas à procura destes por este tipo de cuidados, até ao nível organizacional interno e inter-hospitalar. Fatores de ordem política, direitos laborais, ordens profissionais e a exigência/expectativa da população têm-se mostrado como obstáculos às alterações pretendidas e desejáveis dos SU. No que concerne o funcionamento dos SU, entre outros, existe um problema relativo à colaboração e alocação dos profissionais médicos. O SU é o único serviço cujo funcionamento depende i) de médicos cedidos por períodos até 18 horas/semana, oriundos de outros serviços e ii) de prestadores de serviços externos, que por natureza estão pouco ou nada vinculados ao SU, sendo muitos destes clínicos gerais (indiferenciados) ou internos em formação. Assim sendo, esta volatilidade e heterogeneidade de profissionais nas equipas torna difícil o funcionamento eficaz e sustentado dos SU. Não havendo médicos diferenciados em urgência, com vínculos laborais estáveis e atrativos, dificilmente se conseguem criar SU capazes de responder às exigências atuais e futuras.

Relativamente ao pós-atendimento no SU, o congestionamento de doentes, reflete enfermarias sem capacidade de resposta, além do problema dos internamentos prolongados injustificados e dos casos sociais que se acumulam. O funcionamento das diferentes enfermarias enfrenta obstáculos vários, sendo o denominador comum à maioria destes, a falta de médicos especialistas que observem e orientem os casos, que tenham disponibilidade e capacidade para dar resposta aos exames complementares de diagnóstico (p.ex. de exames de imagem) e ainda de médicos disponíveis que tenham tempos de bloco operatório para se realizarem cirurgias. No que aos casos sociais se refere, o problema passa em boa parte pela incapacidade de as famílias darem apoio no domicílio e à resposta insuficiente das diferentes redes de cuidados de convalescença (curta, média e longa duração) e paliativos, das ERPI, da hospitalização domiciliária e das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC).

As propostas do PES pretendem intervir em algumas das diferentes dificuldades apontadas, que resultam em constrangimentos antes, durante e após o SU contribuindo para a excessiva afluência e utilização do SU pelas pessoas, dificultando o circuito do doente, bem como o seu escoamento para fora do SU.

2. Apresentação Sumária das Medidas

A.1 | Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica

Remodelar e criar espaços de atendimento, com foco nas urgências psiquiátricas, para melhorar a qualidade do atendimento. A implementação será faseada (publicação de regulamento, financiamento, concurso, contratação e monitorização).

A.2 | Criação de Centros de Atendimento Clínico (CAC) para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica

Construir uma “coroa” de locais em redor de cada hospital, para atender doentes que a triagem de Manchester (no SU, SNS 24 ou CODU) determine como não urgentes e pouco urgentes. Os locais de atendimento podem ser CAC, CSP ou Consulta Externa. Inicialmente em Lisboa e Porto depois, conforme os resultados, também noutras áreas.

A.3 | Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência

À imagem do que já se fará em 3 ULS na região norte, pretende-se ser possível agendar consultas do dia seguinte para casos não urgentes em cuidados primários nos CSP (e em caso de doentes acamados, para o próprio dia).

B.2 | Criação da Especialidade de Médica de Urgência

Formar médicos especialistas em Medicina de Urgência, à imagem do que acontece na maioria dos países da união europeia. Processo que passa pela aprovação e criação da especialidade (previstos até ao final de 2024) e que se criem as primeiras vagas para o internato de formação específica em 2025.

3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

A implementação eficaz das medidas do eixo 3 do PES poderá beneficiar de uma análise dos princípios económicos subjacentes, a fim de garantir a sustentabilidade e a efetividade do sistema a longo prazo. Este eixo 3 visa promover decisões mais informadas e alinhadas com o Modelo de Grossman do ponto de vista do indivíduo, que concebe a saúde como um bem de investimento a ser continuamente cultivado para manter o seu capital de saúde. O acesso a cuidados hospitalares pelas pessoas corresponde ao princípio da "procura por cuidados de saúde" exatamente como forma de investimento e recuperação do capital de saúde, para recuperar perdas associadas a acidentes e doenças em situações de urgência e emergência.

A procura dos SU pressiona os recursos físicos e humanos limitados do SNS, criando um cenário de escassez que exige soluções inovadoras e eficientes. A Economia da Saúde analisa esta problemática através da escolha racional dos agentes, compreendendo os fatores que influenciam a procura por serviços de saúde e assim, auxilia na forma como vai alocar esses recursos para otimizar os resultados.

A análise custo-efetividade, utilizando ferramentas como o ICER (Incremental Cost-Effectiveness Ratio) e o indicador QALY (Quality-Adjusted Life Years) ou outros de qualidade de saúde, serve para avaliar a relação entre os custos e os resultados em saúde das medidas propostas pelo eixo 3. Assim, vamos focar as medidas que se nos afiguram como aquelas que serão ou tenderão a ser mais eficientes do ponto de vista do custo por unidade de benefício em saúde, melhorando-se decisões estratégicas na alocação de recursos. Deste modo, analisam-se os benefícios em saúde que poderiam ser alcançados caso os recursos fossem alocados de forma distinta.

A.1 | Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica

Quanto à produção de cuidados de saúde de urgência geral/psiquiátrica a medida visa aumentar a eficiência e capacidade de resposta dos SU. No entanto é omissa como será abordada a outra componente necessária - os recursos humanos. O custo de oportunidade (CO) dos 20 milhões de euros investidos representa recursos que não são alocados na resolução de outras necessidades de saúde. O mercado de SU pode definir-se como um mercado que compreende o sector público, mas também o privado. Ora, esta medida surge exactamente porque a oferta está aquém da procura. Contudo, embora

existam SU em unidades privadas, o acesso a estas depende da condição económica dos doentes, não sendo por isso universal. Por outro lado, a oferta nestas unidades tende a ser mais limitada na abrangência do que aquela que é oferecida pelo SNS, sobretudo em termos de complexidade clínica. Relativamente às urgências psiquiátricas, se considerarmos a oferta pelo sector privado, seja em consultórios ou em hospitais privados, podemos observar igualmente um sector com “falhas de mercado”, no sentido em que é quase inexistente esta oferta, fazendo a intervenção do Estado fundamental.

Embora existam taxas moderadoras nos SU (o valor de €16 pela inscrição e até um limite máximo de €40 euros por episódio), segundo os estudos realizados [5,6], a elasticidade-preço da procura, quer para adultos, quer para crianças, é próxima de zero (procura inelástica). Tomando o número de episódios de urgência como uma das formas de aferir a procura dos SU e observando a sua evolução ao longo do tempo no Portal da Transparência, observa-se que a procura se tem mantido mais ou menos estável desde 2013 (excepto nos anos da pandemia de COVID-19). Já no que diz respeito às urgências psiquiátricas, estas têm aumentado desde 2020 [7]. O objectivo da melhoria dos tempos de resposta dos SU requer a compreensão do efeito resultante do aumento da quantidade de prestação, da melhoria da organização e/ou da qualidade dos espaços sobre esse tempo. Tal poderá ser aferido, por exemplo, através da variação nos tempos de espera para observação dos doentes, após a triagem, resultante do acréscimo de um gabinete de atendimento e adição de X horas de trabalho médico por semana (ou seja, uma análise marginal).

A.2 | Criação de Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica

A produção de cuidados de saúde para situação agudas de menor complexidade e urgência clínica preconiza a oferta de 24 a 36 gabinetes para uma procura de até 1000 doentes/dia em Lisboa e no Porto, estando omissa a quantidade de horas de trabalho de gestores, médicos, enfermeiros, auxiliares de ação médica e administrativos necessárias para alcançar o objetivo proposto. Não se encontrando estimado o custo deste investimento, não é possível apreciar o custo-oportunidade que concorreria com investir em programas de literacia em saúde e prevenção da doença para população, reforço da resposta dos cuidados de saúde primários com equipas de médico e enfermeiro de família suficientes e com condições para dar resposta cabal a doentes sem médico de família, criar condições base que permitam manter e atrair mais profissionais.

O mercado do SU compreende também os doentes não urgentes e pouco urgentes que hoje recorrem aos serviços de urgência, CSP e outras consultas (nos públicos e privados). Uma vez que se desconhece se o acesso terá algum valor associado e a adesão a este, não é possível analisar a elasticidade da procura do SU e de outros serviços com resposta às necessidades de cuidados idênticas. O fomento da substituíbilidade entre diferentes serviços oferecidos poderia passar pela comparticipação e/ou acordos com unidades privadas (consultórios, clínicas, hospitais) para observarem esta tipologia de doente.

A.3 | Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência

Nesta medida A3, a produção de cuidados de saúde para situações agudas de menor complexidade e urgência, visa fomentar o número de consultas agendadas a partir dos diferentes pontos de contato com o SNS (SU, SNS 24 e CODU). O investimento necessário não se encontra especificado no PES. Mas calcula-se que terá de passar tanto pelo reforço de recursos materiais como humanos para atendimento de chamadas; inclui também atualização dos programas de triagem e formação de profissionais, e ainda investimento em recursos para atendimentos dos utentes referenciados. O custo desta medida é de difícil estimação, não sendo por isso possível perceber o potencial impacto no orçamento do Ministério da Saúde.

B.2. | Criação da Especialidade de médica de Urgência

A produção especialista de urgência médica depende de quantas unidades têm idoneidade formativa e do número de orientadores (dados desconhecidos). Os recursos utilizáveis são, por um lado, os médicos que associam duas condições: ser-lhes atribuída dupla-titulação (somar à especialidade que já têm, a especialidade de Medicina de Urgência) e que se encontrem disponíveis para integrar um contingente de orientadores. Por outro lado, os médicos que queiram e estejam em condições de escolher uma vaga para o programa de formação específica desta especialidade ou que pretendam cumprir um ciclo de estudos correspondente (via alternativa para especialistas).

Outros recursos relevantes para esta medida são as estruturas como os SU e os serviços onde os internos terão de cumprir os estágios da especialidade. O CO desta medida, uma vez que também não se encontram dados concretos do investimento envolvido, poderá ser estimado de forma muito incompleta, recorrendo a alguns dados informativos. De acordo com o relatório de Evolução do Desempenho do SNS, em 2023, elaborado pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP), é referido um gasto de 164,4M€ com serviços médicos externos, a somar ao gasto com horas suplementares de 185,2M€. Contudo, este gasto têm um impacto superior dado que ao especializar médicos, irá diminuir despesas diversas tais como pedidos de meios complementares e de diagnóstico (MCD), prescrição de terapêutica no SU e para o domicílio, em consultas externas e internamentos, pode também diminuir as comorbilidades e complicações várias. O mercado inclui os SU básicos, SU médico-cirúrgicos e os centros de atendimento clínico (CAC), mas também no pré-hospitalar nas Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM e Serviço Helicóptero de Emergência Médica (SHEM). Estes médicos especialistas em Urgência Médica não podem ser efetivamente substituídos, muito embora até hoje estas funções sejam desenvolvidas por clínicos gerais (médicos sem especialidade), por internos em formação específica e especialistas de outras áreas.

4. Rever ou reforçar as medidas propostas

Efetuando uma reflexão crítica, há necessidade e oportunidade para contribuir e melhorar o documento apresentado, além de incluir novas propostas, e assim no seu todo, seja possível dar uma resposta mais eficiente e eficaz às necessidades da população.

A.1 | Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência Geral/Psiquiátrica

No contexto atual em que a procura tem sido mais ou menos estável, a necessidade de requalificar os SU pode ser em parte inerente ao desgaste destes, à evolução das formas de organização e à qualidade da resposta pretendida.

Da análise global do PES, não deixa de ser paradoxal desenhar um PES com um foco na limitação do acesso aos SU, no desenvolvimento de estratégias para criar “coroas” e “alternativas” aos SU, e ao mesmo tempo, investir na requalificação das condições dos SU gerais e psiquiátricos.

Relativamente à criação de novos espaços, nomeadamente para o atendimento de urgências psiquiátricas, há que ter em atenção a especificidade dos mesmos, quer no âmbito dos espaços e a segurança (dos utentes e prestadores de cuidados de saúde), quer na articulação com outros serviços ou unidades de cuidados, com capacidade para internamento, quando necessário. É também de relembrar que para que o espaço do SU seja desenvolvido de forma adequada, é imprescindível o valioso capital humano. Apesar de não haver escassez de médicos psiquiatras por cada mil habitantes, existe uma falta de condições laborais que não permitem fixar os médicos ao SNS. Não tem sido e não será uma estratégia viável, e menos ainda sustentável no tempo, acenar com incentivos monetários para aumentar a produção. A classe médica, e os psiquiatras em particular, sabem que este tipo de estratégia serve alguns e não reflete as mudanças das condições base e estruturais necessárias para garantir a estabilidade e atratividade. Atualmente, e a título de exemplo, embora alguns os profissionais tenham optado pelo regime de dedicação plena e cumpram as suas exigências, outros nos CSP, que optaram por aumentar as suas listas de utentes, não viram atualizado os incentivos anunciados, de acordo com informações dos sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos. Além do mais, dada a natureza de continuidade e acompanhamento dos cuidados psiquiátricos, a degradação dos serviços e atendimento no SNS será difícil mobilizar os médicos psiquiatras de clínicas e hospitais privados, onde têm estabelecidas as suas carteiras de doentes, para regressar a um SNS.

O SNS depende de quadros governamentais instáveis, frágeis no desenvolvimento de estratégias de longo prazo, sem capacidade de decisão para melhorar efetivamente as condições laborais de base dos profissionais médicos; por outro lado, o SNS sofre um desgaste na sua atratividade por via dos ambientes de conflito entre os responsáveis políticos, administrações, direções, chefias e colaboradores.

Assim, e de forma pragmática, as alternativas passam por duas possibilidades exclusivas:

i) ou mudar o paradigma a que se tem assistido nos últimos anos, evitando a fuga de quadros qualificados do SNS, isto é, criar condições laborais de base melhores, com transparência de processos e seu cumprimento, estratégias e regras definidas e sustentadas no tempo por acordos plurianuais, com condições que sejam aliciantes profissionalmente; então haverá nesse momento a oportunidade para investir na requalificação dos espaços de atendimento para uma resposta adequada,

ii) ou em vez desse investimento (que além da requalificação e manutenção dos espaços, inclui os encargos com ordenados, prémios, incentivos, análises e consumíveis diversos), criar uma estratégia de *outsourcing* em que o Estado contratualiza com prestadores privados de acordo com as suas capacidades negociais.

Qualquer uma destas estratégias pode ser utilizada como trunfo ou arma política; qualquer das duas pode ser muito trabalhada e gerar acusações várias por parte dos diferentes *stakeholders*, seja qual for o partido político que a leve a cabo. Contudo, mais importante do que isso, é fazer uma análise pragmática da realidade: i) não há forma legal de obrigar os médicos que se encontram a cumprir com a lei, com os seus deveres e obrigações, a trabalhar mais horas (o que de si comprometeria sempre a qualidade dos cuidados prestados), ou a abandonar o sector privado em favor do SNS; ii) considerando as leis da oferta e da procura, a grande vantagem do Estado seria, como foi até há duas décadas, a oferta de condições favoráveis para a prática de medicina: o investimento em inovação, a oportunidade de progressão na carreira e ordenados que garantem um adequado poder de compra à classe médica (que permitam uma qualidade de vida compatíveis com a abnegação, responsabilidade, foco e dedicação continua necessárias para garantir qualidade de cuidados e a segurança dos doentes), o ensino, a formação contínua, investigação ; iii) quanto maior a degradação das condições no SNS, maior o desapego e desinteresse dos profissionais de saúde, maior o crescimento o sector privado e maior a emigração de profissionais de saúde.

A.2 | Criação de Centros de Atendimento Clínico para situações agudas de menor complexidade e urgência clínica

A sobrecarga dos SU com casos não urgentes e pouco urgentes compromete a eficiência e a segurança dos outros atendimentos urgentes e de emergência realizados no SU. Esta medida representa a ideia do investimento na descentralização de cuidados de saúde agudos. No passado existiram os Serviços de Atendimento Permanente (SAP), um maior número de Serviços de Urgência Básica (SUB) e também um maior número de horas de consultas abertas nos CSP. E é exatamente por aqui que começamos este comentário: estas respostas foram eliminadas não por opção ou outras melhores soluções, mas como forma de ajustamento à falta de médicos no SNS. Assim, dada a carência crescente de MGF nos CSP, interroga-se a viabilidade desta medida no espaço temporal proposto ou até nos próximos 6 anos. Se não, veja-se: pode ser argumentado que uma vez que haverá menos utentes nos SU, haverá também a possibilidade de deslocar os médicos dos SU para os Centros de Atendimento Clínico (CAC). Contudo, a realidade é que os médicos que estão nos SU, são poucos para observar atempadamente todos casos que existem, os não urgentes, os urgentes de diferente ordem e os emergentes. Uma vez atingido o objetivo de evitar a ida dos não urgentes e pouco urgentes aos SU, talvez os atuais médicos do SU, consigam finalmente dar uma resposta adequada aos restantes doentes urgentes e emergentes que recorram aos SU. Caso estes médicos sejam deslocados para os CAC, continuará então a haver um défice de médicos para observar o volume de doentes continuam a recorrer e a necessitar de atendimento nos SU. Desta forma, i) uma vez que atualmente existe uma carência de especialistas de MGF nos CSP, não se prevendo que se possa mobilizar estes profissionais para os CAC, e ii) considerando que existe um crescente número de médicos reformados não compensado com médicos recém-formados, então levanta-se um problema básico: podem não existir médicos em número suficiente para responder aos 24 gabinetes nos CAC de Lisboa e do Porto.

Se analisarmos a resposta pretendida para o conjunto dos CAC em Lisboa e no Porto (até 1000 doentes/dia), num cenário meramente matemático e hipotético, se forem

implementados 36 gabinetes/médicos, a trabalhar 8 horas/dia, com uma média de 15 minutos de tempo total por doente, resulta que cada médico orientaria 4 doentes/hora, o que equivale a cada médico dar resposta a 32 doentes em 8 horas, o que equivale a que se observassem 1152 doentes/dia. Ajustando apenas o tempo máximo efetivo que cada médico trabalha, mantendo um cenário onde se conseguem ter 36 médicos a trabalhar 6,5 horas efetivas por dia (1 hora e duas pausas de 15 minutos subtraídas de 8 horas), com uma média de 15 minutos de tempo total por doente, daria que cada médico orientaria 4 doentes/hora, o que equivale a cada médico dar resposta a 19,5 doentes em 6,5 horas, o que equivale a 936 doentes/dia.

Se ao anterior ajustarmos o tempo necessário para a prática de medicina de qualidade e em segurança, onde se respeitem os diferentes componentes de uma consulta médica deste tipo, onde será necessário colher uma história clínica focada, uma *anamnése* dirigida, observar qualitativa e quantitativamente (parâmetros vitais por exemplo) o doente, com necessidade de uma eventual leitura e interpretação de MCDT que o doente traz, ou que seja necessário fazer no CAC, e uma orientação clínica, seja para o domicílio com provável prescrição eletrónica e esclarecimento do doente e a sua concordância com o plano, seja se necessária orientação para um SU, com necessário contacto com o SU e posterior pedido de transporte, é, no final, desonesto pensar-se que a média de 15 minutos por doente será possível no mundo real. Assim, se ajustássemos este tempo para meramente 20 minutos/doente (que para tratar de tudo continua a ser pouco para esta tipologia de doente), então se existissem 36 médicos a trabalhar 6,5 horas/dia, a resposta dos CAC seria de 702 doentes/dia. Temos de lembrar a vertente da realidade desta tipologia de doentes. Estamos a falar de pessoas com necessidade de ver orientada uma série de assuntos, falar de mais do que uma queixa, ver esclarecidas dúvidas e teorias de várias ordens que criaram e que finalmente conseguem consultar um médico. Entre a empatia pela situação, queixas clínicas, sobre sistema e os serviços e tudo o já referido, é muito difícil para quem conhece a realidade no terreno acreditar que estas contas estejam sequer perto de refletir o número real de doentes que seriam possíveis observar, assim conseguissem o já muito pouco provável melhor cenário relativo ao número de médicos a prestar serviço.

Esta medida apresenta, contudo, outro problema numa fase anterior da chegada dos doentes ao CAC: o encaminhamento dos doentes ao SU e ao CAC depende da tipologia de triagem. Ora, o sistema de triagem realizada pelo INEM CODU e pelo SNS24 não é o mesmo que é utilizado pelos SU, que é o sistema de triagem de Manchester.

Aliás, cada serviço adotou um sistema de triagem de acordo com as suas missões de base. Por outro lado, nos casos do sistema do INEM e da linha SNS24, as triagens são realizadas por profissionais com um declive de diferenciação académica substancial. No INEM a triagem é realizada por técnicos formados pelo próprio INEM, com diversos níveis de escolaridade (desde terem apenas o ensino obrigatório até profissionais com cursos superiores) e de diversas áreas base do conhecimento, ao passo que triagem na linha SNS24 é realizada por enfermeiros. Sendo comum que o encaminhamento nestes dois pontos de contato com SNS requer um atendimento telefónico, é de prever uma procura maior destes serviços após a implementação desta medida. Atualmente, quer no CODU do INEM, quer na SNS24, há atualmente múltiplos constrangimentos no atendimento, com incapacidade de resposta dentro dos tempos preconizados como máximos. Não existindo melhoria das condições remuneratórias e laborais, não será possível atrair e manter profissionais dispostos a estas funções exigentes de responsabilidade e dificuldade.

Por fim, no que respeita ao transporte de doentes a partir dos SU, o PES refere que o encaminhamento para os CAC poderá “ser agilizado pelo hospital ou através de parceiros”. Contudo, também é bem conhecida a enorme dificuldade que os hospitais têm em articular os parceiros fornecedores de transporte (empresas privadas de transporte de doentes não urgentes, Bombeiros Voluntários e pela Cruz Vermelha). Também são reconhecidas as carências de meios na emergência médica pré-hospitalar, pelo que não se pode contar com a mobilização destes meios para este propósito. Prevendo-se que esta medida incremente o número de transporte de doentes, é de prever também uma grande dificuldade na concretização destes transportes e um agravamento dos tempos de espera para realizar estes serviços.

A.3 | Implementação da consulta do dia seguinte nos Cuidados de Saúde Primários para situações agudas de menor complexidade e urgência

Partindo do mesmo princípio apresentado no documento, “o respeito pela missão dos SU”, esta medida conflitua com o respeito pela autonomia do médico de MGF na gestão da sua agenda. Este aparente desconhecimento da dinâmica e da realidade dos CSP, em particular, dos constrangimentos atuais e da gestão e funcionamento da agenda do médico de MGF e da enfermagem de família.

A MGF tem por missão promover a saúde a nível da prevenção primordial, primária e secundária, o acompanhamento do utente desde a primeira semana de vida até à última, passando por monitorizar o bom desenvolvimento da criança e adolescente, promover a vacinação, acompanhar a saúde do adulto, promover o diagnóstico precoce de doenças, garantir o acesso e cumprimento de terapêuticas, permitir uma idade sénior de qualidade, articular os cuidados domiciliários e os paliativos na comunidade, contribuir para a cultura, condições sociais, físicas, psicológicas e existenciais dos utentes para que tenham as melhores condições para atingir um bem estar global, ao mesmo tempo que se identifica, conhece e desenvolvem estratégias para apoiar utentes vulneráveis e em risco. Na ausência de capacidade para cumprir estas missões cabalmente, foram criados cinco programas de saúde prioritários. Sendo que mesmo estes programas têm ficado por responder dada a insuficiente resposta nos CSP. Ainda assim a MGF, uma trave-mestre do SNS e da saúde da população, é precisamente a especialidade a quem se atribuem as tarefas que não cabem noutros pontos de prestação do SNS.

B.2 | Criação da Especialidade de Médica de Urgência

A criação da especialidade de médica de urgência é há muito vista como uma das componentes necessárias para resolver a problemática crónica da falta de resposta dos SU. A introdução de especialistas em medicina de urgência irá permitir que a resposta do ponto de vista clínico seja, não só melhor, mais segura e de maior qualidade, mas também com melhor orientação à entrada e à saída, e por isso mais fluída dentro do SU.

Além disso, a existência destes profissionais irá permitir que um número crescente de médicos assuma um compromisso e adquira um conhecimento da área da urgência que permita a sua dedicação a esta área e a criação de equipas próprias dos SU. Contudo, é uma medida sem efeitos significativos imediatos, os seus efeitos far-se-ão sentir a médio

(5 anos) e longo prazo. A diferenciação e espectro de ação dos especialistas precisa de ser balizado e articulado atualmente com as diferentes especialidades existentes.

No geral, no que diz respeito a esta especialidade, não há medidas que tenham qualquer impacto sustentado, reestruturante, refundador, que não passe por melhorar as condições profissionais dos médicos. O aumento das vagas de estudantes de medicina não garante que haja profissionais interessados em prosseguir esta especialidade que requer elevados níveis de responsabilidade, de exigência e de stress laborais e que requer uma atualização de conhecimentos constantes. Esta especialidade não é, de facto, compatível com as atuais condições profissionais oferecidas no SNS. Continuar a estimular um complexo relativo ao salário de um médico no SNS, só irá continuar a afastar os médicos na direção do sector privado, a enfraquecer a resposta possível aos utentes e a capacidade de formação no SNS. É urgente reverter a perda de poder de compra que se tem constatado na classe médica nos últimos 10 anos, e desenvolver adicionalmente programas de incentivos e prémios, quando possível. Com estas estratégias de nivelamento por baixo, está-se a dificultar esse acesso aos cuidados de saúde por falta de profissionais no SNS. Sem resposta no SNS, dependendo da prestação dos privados, a população fica mais suscetível à lei de oferta e da procura em mercados imperfeitos e com isso a preços elevados.

Referências

1. Entidade Reguladora da Saúde (ERS). (2009). Estudo sobre os conceitos de “serviço de urgência” e “serviço de atendimento permanente” em estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde não público .
https://www.ers.pt/uploads/writer_file/document/68/estudo_sobre_urgencias-sap_privadas.pdf
2. Serviço Nacional de Saúde (SNS). (2019). Relatório Grupo Trabalho - Serviços Urgência . <https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2019/11/RELATORIO-GT-Urg%C3%A2ncias.pdf>
3. Diário da República, 1.^a série, n.º 71. (2014). Portaria n.º 82/2014 de 10 de abril, Artigo 1.º.
4. Manchester Triage System . (2024). <https://www.triagenet.net/classroom/>
5. Soares, S. (2013). Aumento das taxas moderadoras nas urgências hospitalares: Que impacto sobre a procura? (Tese de Mestrado). Escola Nacional de Saúde Pública.
<http://hdl.handle.net/10362/11372>
6. Quintal, C., Tavares, H. M., & Lourenço, O. (2016). Impacto das taxas moderadoras sobre a utilização de cuidados de saúde pediátricos: Estudo aplicado a crianças em idade escolar na cidade de Coimbra. *Revista Portuguesa de Saúde Pública*, 34 , 154–162.
7. Monitorização do SNS. (2024). Urgências psiquiátricas .
<https://www.sns.gov.pt/monitorizacao-do-sns/>
8. Conselho de Finanças Públicas (CFP). (2024). Desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023 (Relatório 07/2024). Lisboa.

Eixo Estratégico 4 | Saúde Próxima e Familiar

Francisco José Silva Ribeiro

Inês Sofia Morgado Rodrigues

Sara Fonseca Lopes

Sumário

Eixo Estratégico 4 Saúde Próxima e Familiar	41
Sumário	41
1. Contextualização do problema	41
2. Apresentação sumária das medidas	42
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	46
4. Rever ou reforçar as medidas propostas – comentário	48
Referências	50
Anexos	51

1. Contextualização do problema

Papel dos cuidados de saúde primários no SNS

A criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 1979 representou uma transformação significativa na organização dos cuidados de saúde em Portugal. Em 1982, foi estabelecida a carreira médica de Clínica Geral. No ano seguinte, foram criados os Centros de Saúde de segunda geração, introduzindo o Médico de Família como um elemento inovador. Contudo, somente em 1990 foi instituída a especialidade de Medicina Geral e Familiar (MGF) [1].

Os médicos de MGF são perspetivados na literatura económica como *gatekeepers* do SNS. Este controlo de acesso aos cuidados hospitalares e de especialidade geralmente envolve um sistema sequencial de assistência prestada de diferentes médicos, que os utentes devem consultar. Ao nível do SNS, a referenciação para consulta de especialidade, implica a avaliação prévia por parte do médico de MGF, como forma de certificar a necessidade de uma consulta com um especialista. Ao limitar-se um acesso direto às restantes especialidades, permite-se uma organização menos dispendiosa da prestação de cuidados de saúde, ao reduzir-se os efeitos do risco moral pela redução das consultas desnecessárias, e reservando estas para utentes que carecem de cuidados diferenciados [2].

Problemática atual

Segundo dados do relatório “Evolução do Desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023”, do CFP [3], nos últimos 5 anos, verificou-se um crescimento anual de 20% no número de utentes sem médico de família atribuído. Existiam assim, no final de 2023, cerca de 1,7 milhões de portugueses sem médico de MGF, perfazendo 16% do total de inscritos no SNS, sendo as regiões de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Algarve e Leiria as mais preocupantes [4].

Esta problemática surge principalmente pelo aumento das necessidades de cuidados de saúde por parte da população, resultantes de um incremento da esperança de vida e, consequentemente, a uma maior prevalência da doença crónica. Esta situação reflete um desequilíbrio económico em que a procura é maior do que a oferta de cuidados de saúde. Decorre daqui, primeiramente, que os menores níveis de prevenção e de gestão de doenças crónicas possam resultar em desfechos desfavoráveis que acarretam custos acrescidos para o SNS. E em segundo lugar, não existindo resposta suficiente ao nível do setor público, estimula-se o recurso a cuidados de saúde no sector privado, acentuando as desigualdades sociais na população.

2. Apresentação sumária das medidas

Medidas urgentes

Medida A.1 | Afetação de Médicos de Família aos utentes em espera com a capacidade atual do setor público

O objetivo desta primeira medida visa melhorar a distribuição de Médicos de Família, atualizando as listas de pacientes das ULS e considerando a necessidade e uso dos cuidados de saúde primários. Para além disso objetiva, facilitar a atribuição imediata de Médicos de Família para a população em espera, priorizando os mais necessitados com base em critérios de estratificação de risco. Para tal, proceder-se-á à identificação de portugueses no exterior que não têm consultas há mais de 5 anos e atribuir os seus médicos de família a residentes em Portugal que utilizam os centros de saúde. Isso permitirá atribuir Médicos de Família a aproximadamente 130.561 utentes e desativar o registo de 49.796 não residentes e 80.767 residentes estrangeiros sem consulta recente.

Medida A.2 | Reforço da resposta pública dos Cuidados de Saúde Primários em parceria com o setor social

Esta medida tem como objetivos aumentar a oferta de cuidados de saúde primários públicos para garantir acesso equitativo e regular aos serviços de saúde essenciais. Para tal, pretende-se endereçar a crítica falta de Médicos de Família em Portugal mobilizando o setor social, incluindo a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e a Cruz Vermelha Portuguesa, para alocar médicos assistentes. Para tornar este regime mais apelativo pretende-se que o modelo de financiamento seja baseado em preço por utente, com um volume máximo de utentes por instituição, distribuídos conforme a proximidade, permitindo às instituições do setor social prescreverem medicamentos, MCDT, e façam referenciações hospitalares. Adicionalmente pretende-se estratificar os utentes por risco após a atribuição inicial, priorizando grávidas, menores de 12 anos, adultos com mais de 55 anos e portadores de doenças crónicas. De forma prática, objetiva-se atribuir médicos

assistentes a 350 mil utentes (300 mil pela Misericórdias e 50 mil pela Cruz Vermelha), focando em áreas carentes como Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve, para melhorar a cobertura e promover a equidade no acesso aos serviços de saúde.

Medida A.3 | Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Parceria Público-Privada com Hospital de Cascais)

A terceira medida emergente visa criar capacidade adicional de cuidados de saúde primários para beneficiar diretamente os utentes das ULS de Lisboa Ocidental e Amadora-Sintra, áreas com grande escassez de Médicos de Família (mais de 110000 utentes) [5] ⁽⁷⁾. A ideia piloto começaria com a PPP de Cascais que serviria para ampliar a oferta de serviços de saúde, reforçando a Parceria Público-Privada (PPP). O Hospital de Cascais possui capacidade instalada suficiente para atender 75.000 desses utentes e garantir todos os meios complementares de diagnóstico e terapêutica necessários, proporcionando uma resposta mais eficaz e eficiente aos desafios do sistema de saúde.

De acordo com o referido pela Ministra da Saúde no dia 31 de maio de 2024, pretende-se criar a Unidade Local de Saúde Sintra/Cascais, EPE (ULS, EPE) com um hospital público em gestão com parceria público-privada (PPP). Portanto, seria uma primeira PPP a envolver os cuidados de saúde primários abrangendo os atuais utentes sem médico de família, atualmente nas ULS Amadora-Sintra (residentes em Sintra Ocidental) e ULS Lisboa Ocidental (residentes em Cascais). Sendo o objetivo do plano abranger cerca de 88000 utentes até ao final de 2024.

Medida A.4 | Criação de linha de atendimento para utentes que necessitem de acesso a médico no dia

A 4ª e última medida emergente deste Plano de Emergência no eixo de Saúde Familiar mais próxima, pretende estabelecer um canal de comunicação direto para utentes que precisam de acesso a um Médico de Família ou médico assistente no mesmo dia. Facilitando a atribuição de médicos assistentes aos utentes elegíveis por meio de uma via de contacto dedicada. Na primeira fase, a linha fará chamadas ativas (*outbound*) para atribuir médicos assistentes a utentes sem Médico de Família. Posteriormente, utentes poderão contactar proactivamente a linha para solicitar um médico assistente. Esta abordagem bidirecional garante que todos os utentes sejam considerados para a atribuição de médicos assistentes, otimizando o processo. A linha permitirá também que entidades de Cuidados de Saúde Primários solicitem consultas imediatas para utentes sem Médico de Família através do setor social e privado.

Medidas prioritárias

Medida B.1 | Implementação de USF-modelo C

Com o intuito de potenciar a capacidade do SNS na prestação de CSP, equaciona-se a criação e implementação de um modelo complementar de organização (USF-modelo C), principalmente nas regiões com menor cobertura de MGF (Lisboa, Algarve e Leiria).

Ressalva-se, contudo, a importância da manutenção do reforço da estrutura atual, com expansão de USF modelo B. As USF-modelo C são entidades que estabelecem um contrato-programa com as ARS e que detêm autonomia organizacional e financeira.

Decorrente da responsabilização acrescida das equipas de saúde, este modelo incentiva a contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados e satisfação dos utentes.

Deste modo, propõe-se o início de funções ainda no ano vigente de 4 agrupamentos de USF-modelo C, cada um constituído por 5 USF. Incidindo cada agrupamento sobre uma base populacional de 45 mil utentes, perfaz-se uma capacidade total de 180 mil utentes (90 mil em LVT)

Durante 2025 prevê-se a criação de 4 novos agrupamentos na região de Lisboa. Estes concursos permitiriam cobrir uma cobertura populacional de 360.000 utentes (23% da totalidade de utentes atualmente sem MGF).

Medida B.2 | Reforço da resposta pública com médicos aposentados

A presente medida visa colmatar lacunas temporárias da capacidade dos CSP, por meio de um reforço na contratação de médicos aposentados, segundo o regime excecional estabelecido pelo Decreto-Lei nº89/2010. Este recrutamento deve cumprir o estipulado no artigo 24º da Lei do Orçamento de Estado para 2024, bem como os contingentes definidos. Deste modo, propõe-se um aumento da remuneração base, correspondente à categoria, de 75% para 100%, à qual acresce 50% dos incentivos indexados ao IDE, caso desempenhem funções numa USF-modelo B. Pretende-se que este regime transitório não comprometa a renovação dos quadros.

Medida B.3 | Revisão dos critérios de transição de USF-modelo A e UCSP e para USF-modelo B

Reconhecendo-se a USF modelo B como detendo uma maior autonomia de gestão e padrões de qualidade superiores, pretende-se promover a transição de UCSP e USF-modelo A para USF modelo B. Para tal, esta medida propõe-se a reduzir o Índice de Desempenho Global (IDG) necessário à ocorrência desta transição de 60% para 50%, aliado ao ajuste dos critérios de acesso a USF-modelo B, consoante a realidade verificada nas regiões de baixa densidade.

Medida B.4 | Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Associações de Médicos e Cooperativas)

Com vista ao fortalecimento da capacidade de prestação de CSP, a nível do SNS, garantindo uma cobertura de cuidados mais abrangente e eficiente, equaciona-se a colaboração entre os setores público e privado na área da saúde. Por meio da ACSS, procurar-se-ia o estabelecimento de convenções para contratação, por parte das ULS, de serviços privados. Estas convenções nacionais devem definir regras e diretrizes claras, assegurando a transparência e equidade na definição de preços, bem como qualidade dos cuidados.

Deparando-se com limitação da capacidade disponível, seria responsabilidade da ULS a ativação destas convenções, via lançamento de concursos públicos. As cooperativas e associações de médicos responsabilizar-se-iam consequentemente pelo tratamento de parte dos doentes dessas ULS, com base nos acordos previamente estabelecidos.

Medida B.5 | Incentivo à adesão ao regime voluntário de carteira adicional de utentes

A medida apresentada tem como intuito acomodar novos utentes aos CSP do SNS, estabelecendo um regime voluntário que possibilite o incremento da carteira de utentes por médico. O regime facultativo apresentado corresponde a uma medida transitória, com duração de 5 anos, que estipula um valor máximo de 200 utentes a serem adicionados voluntariamente às respetivas listas. Procura-se assim, um incremento da capacidade de resposta às necessidades da população. Ressalva-se a importância de uma auscultação prévia dos sindicatos e associações da MGF.

Medidas estruturantes

Medida C.1 | Disponibilização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica em química seca e radiologia convencional

Tem como alvo a população geral, tendo como principais objetivos fomentar o diagnóstico antecipado e tratamento de patologias detetáveis através de meios complementares de diagnóstico (MCDT) de química seca e radiologia convencional, dotar os CSP de MSCT adequados e democratizar o acesso a MCDT e reduzir a necessidade de encaminhamento para centros especializados.

A química seca permite uma rapidez na obtenção de resultados sem risco elevado de contaminação. Permite a realização de uma ampla gama de testes bioquímicos, facilitando o diagnóstico e o acompanhamento de condições crónicas (exemplo: diabetes e dislipidemias). Esta deverá ser implementada em diversos centros.

O raio-x nos CSP permite um diagnóstico imediato em diversas situações, como é o caso de fraturas ósseas e patologia pulmonar, através da telemedicina. A possibilidade de realizar as radiografias no próprio local é benéfico em zonas remotas ou com recursos limitados (sem acesso a tecnologias avançadas). Este deverá ser implementado de forma progressiva ao abrigo do PRR.

Medida C.2 | Dinamização de rastreios oncológicos nos Cuidados de Saúde Primários

Tem como alvo a população geral, tendo como principais objetivos promover a prevenção de doenças oncológicas, facilitar o acesso dos utentes ao rastreio de doenças oncológicas e alargar o papel dos CSP na prevenção das doenças oncológicas.

Atualmente, os planos nacionais de rastreio oncológico, sob coordenação da DE-SNS, dependem da operacionalização pelas ULS. A expansão destes rastreios para os CSP representa uma melhoria da saúde pública. Além de evitar despesas em produção oncológica nos hospitais, é mais acessível aos utentes.

Considerando que o cancro colorretal é a segunda maior causa de morte em Portugal, torna-se essencial expandir os rastreios na área da Gastroenterologia. É também essencial a revisão da convenção para a realização de colonoscopias, incentivando a prática de rastreios regulares e possibilitando a intervenção precoce.

Medida C.3 | Criação de Centros de Avaliação Médica e Psicológica

Tem como alvo a população geral que necessite de Atestado de Robustez Física e Psíquica para fins diversos e os Médicos de Medicina Geral e Familiar dedicados a atividades assistenciais. Esta medida apresenta como principais objetivos libertar os CSP da emissão de documentos para fins Fiscais e Sociais e garantir a resposta centralizada e otimizada, ao nível das ULS, para emissão dos atestados.

A criação de Centros de Avaliação Médica e Psicológica (CAMP) funcionarão como unidades autónomas e contarão com profissionais especializados nas áreas de medicina e psicologia. Assim, os médicos dos CSP poderão focar-se no atendimento clínico dos utentes, libertando-se de funções administrativas.

3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

Medidas urgentes

Medida A.3 | Reforço da resposta pública em parceria com o setor privado (Parceria Público-Privada com Hospital de Cascais)

No final do 3.º trimestre de 2023, os encargos líquidos acumulados com as parcerias do setor da saúde ascenderam a 95,3M€, o que corresponde a uma execução abaixo do valor orçamentado em 15% (-16,8M€). Adicionalmente, e comparativamente com o período homólogo de 2022, os encargos acumulados do 3.º trimestre de 2023 tiveram uma redução de 24% (-29,9M€).

O Relatório Síntese do Tribunal de Contas de 2021 [6] concluiu que as 4 parcerias público-privadas hospitalares existentes no período 2008-10 geraram poupanças ao erário público, apesar da produção contratada ter sido inferior à produção realizada, que foi marginalmente remunerada ou não remunerada. A PPP do Hospital de Cascais, a única atualmente vigente, representa uma mais-valia para o SNS pois permite um melhor acesso aos utentes desta região, sendo o seu custo-benefício favorável. Aliás, um estudo da Entidade Reguladora da Saúde de 2016 [7] concluiu que os hospitais PPP podem registar alguns indicadores melhores do que os hospitais EPE do SNS, dadas as suas características estruturais e de gestão, apesar de também apresentarem algumas desvantagens comparativas não despreciables.

Assim, de uma perspetiva económica as PPP são um modelo de financiamento baseado numa contratualização entre o Estado e uma entidade privada que assegura níveis de prestação e qualidade, que permite uma partilha de risco e garante uma separação entre o agente pagador e o agente prestador, que pode ser uma alternativa bem-sucedida na resposta às necessidades de saúde da população.

Medidas prioritárias

Medida B.3 | Revisão dos critérios de transição de USF-modelo A e UCSP, para USF-modelo B

Os últimos anos foram pautados por uma profunda reforma dos CSP com a criação das USF (Decreto-Lei nº298/2007). Estas unidades apresentam flexibilidade organizacional e

de gestão, regendo-se por metas de qualidade e resultados em saúde, estabelecidos *a priori* na carta de compromisso contratualizada com a respetiva ARS. Em termos de remuneração, esta ocorre segundo um sistema retributivo misto composto pela remuneração base, suplementos e incentivos baseados no desempenho profissional, o designado P4P (*payment for performance* [2]) (Decreto-Lei nº24101/2007). Existe, portanto, um pagamento prospetivo de acordo com a atividade desenvolvida, que pode resultar numa maior cobertura da população pelos CSP.

Em abril de 2024, foi publicado pela ERS um estudo que analisa de forma comparativa a qualidade e eficiência entre os dois modelos de USF em vigor (A e B) e as UCSP, com dados referentes ao período compreendido entre 2019 e 2022 [8]. No que concerne à despesa média com medicamentos prescritos por utente utilizador, as USF-modelo B apresentaram, nos 4 anos, comparativamente às UCSP e USF-modelo A, despesas inferiores de forma transversal a todas as regiões de saúde. (Tabela 1 em anexo) O mesmo se constata na análise da despesa média com MCDT prescritos por utente utilizador, apresentando a menor despesa média relativa. (Tabela 2 em anexo). Em termos de eficiência, uma maior percentagem de USF-modelo B reportou valores acima da média (83,4%), comparativamente com as USF-modelo A (44,5%) e UCSP (21,1%). Deste modo, depreende-se que as USF-modelo B surgem como unidades mais eficientes. E embora se possa argumentar que as USF-modelo B apresentaram uma despesa total salarial acrescida com pessoal médico, de enfermagem e administrativo, a verdade é que este valor é inferior aos ganhos gerados pela menor despesa em MCDT e medicamentos, bem como pelo facto de gerarem mais ganhos em saúde que se traduz em menor gasto com urgências e internamentos evitáveis, reduzindo a respetiva despesa pública [9].

Apesar dos resultados vantajosos das USF-modelo B, a contratualização dos cuidados nestas unidades de saúde assenta num conjunto alargado de indicadores que devem ser revistos periodicamente de forma ajustar-se à demografia e sua evolução (ou seja, considerando a diferenciação dos fatores de risco da população). A contratualização interna nas USF-B, de acordo com os princípios económicos dos incentivos monetários e da teoria da agência, pode degenerar numa medicina baseada em indicadores, em vez de uma medicina centrada no doente [10].

A extinção das ARS e a criação do modelo de Unidades de Local de Saúde veio alterar o processo de contratualização interna dos CSP e gerar incerteza quanto ao processo de transição. Apesar da incerteza ser uma característica habitual no mercado da saúde, do ponto de vista organizacional cria ineficiências e resultados desfavoráveis, como foi o caso da rutura da disponibilidade de vacinas em abril de 2024.

Medidas estruturantes

Medida C.1 | Disponibilização de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica em química seca e radiologia convencional

Os exames de radiologia constituem a terceira maior despesa convencionada com o SNS. Sabe-se que existem 133 concelhos (47,8%) em Portugal Continental sem nenhum estabelecimento com a valência de radiologia. Nos concelhos onde existem estabelecimentos com esta valência, a média é de 4,5 estabelecimentos [11].

No que respeita aos locais de oferta, em julho de 2022, estavam registados no Sistema de Registos dos Estabelecimentos Regulados (SRER) da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) 649 estabelecimentos na área da radiologia, dos quais 550 são estabelecimentos não públicos. Dos estabelecimentos não públicos, 398 (72%) têm convenção com o SNS. Estes 398 prestadores agrupam-se em 144 operadores, sendo que 42 deles representam cerca de 80% da totalidade de requisições aceites no ano de 2021[11].

Os encargos com o setor convencionado de radiologia apresentaram uma taxa de crescimento anual de 4,5% entre 2016 e 2021, sendo que foram gastos 123 milhões de euros, em 2022, em exames radiológicos. Entre 2019 e 2020, os encargos por 1000 habitantes no setor convencionado diminuíram cerca de 25%, contudo, entre 2020 e 2021 aumentaram em 60%. Assim, e dado que os anos da diminuição de 25% se encontram associados ao acontecimento de uma pandemia mundial, prevê-se que continuarão a aumentar no futuro [11].

Em suma, a medida de disponibilização destes MCDT nos CSP poderá, além de melhorar o acesso em regiões mais distantes, aliviar as despesas do SNS em convenções, apesar desta não estar quantificada em termos de valores monetários.

4. Rever ou reforçar as medidas propostas – comentário

Não obstante as medidas apresentadas neste eixo estratégico visarem incrementar a capacidade de resposta aos utentes atualmente sem médico de MGF, não se pode obviar a problemática principal de base que é a escassez de médicos em formação específica desta especialidade. Este facto não resulta do estabelecimento de um número reduzido de vagas de MGF no concurso de ingresso ao Internato Médico, mas antes da não ocupação destas vagas desde 2020. No ano transato de 2023, das 617 vagas abertas a concurso, 262 (42%) não foram ocupadas.

Paralelamente, é estimado que no decurso deste ano, 556 médicos de MGF se reformem, segundo dados do sistema de informação de recursos humanos da SPMS (RHV). Este valor supera em 95 o número de recém-especialistas, traduzindo um saldo negativo de profissionais ativos, que tenderá a agravar-se no futuro. Acresce ainda que apenas cerca de 70% dos médicos recém-formados acabam por ingressar nos concursos abertos a nível do SNS.

Deste modo, pode depreender-se da necessidade procurar uma solução a montante do problema, em particular, o da atratividade de médicos pelo SNS. Ou seja, tornar a prática de MGF no sector público mais atrativa, com vista a incrementar a taxa de inscritos nos concursos e a consequente retenção destes no SNS. Uma possível via de solução passaria pela generalização de USF-modelo B, com uma remuneração baseada em objetivos, ou pela implementação de modelos que conferem maior autonomia organizacional e financeira, diferenciação do modelo retributivo e de incentivos aos profissionais de saúde (como é o caso das USF-modelo C) Essencialmente, conseguir-se-ia tornar a prática de MGF no setor público mais atrativa e assim incrementar o número de vagas preenchidas nos concursos de ingresso ao internato médico nesta especialidade.

De forma emergente pensamos que a valorização dos profissionais através de incentivos, horário flexível, autonomia das USF para organização poderia ajudar a fixar médicos recém-especialistas em regiões como Lisboa e Vale do Tejo, onde nalguns casos o custo

de vida, principalmente habitação, é muito elevado e não atrativo. Uma outra medida de aplicação imediata seria a criação de USF's digitais com médicos de vários pontos do país que respondem à necessidade dos mais novos que optem pela telemedicina. Durante a pandemia do COVID-19 ficou clara a vantagem de utilização da telemedicina, quer para os utentes, quer para os profissionais. Ainda que não seja uma prática adequada a todos os atos clínicos, garantidamente permite ganhos de tempo, financeiros e saúde que não deve ser descurada, sobretudo nas áreas com elevada carência na cobertura de cuidados de saúde.

Referências

1. Leão, I. T. (2019). Medicina geral e familiar: A especialidade do passado, do presente e do futuro. MGFamiliar. <https://www.mgfamiliar.net/blog/medicina-geral-e-familiar>
2. Bhattacharya, J., Hyde, T., & Tu, P. (2014). Health economics . Palgrave Macmillan.
3. Conselho de Finanças Públicas (CFP). (2024). Desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023 (Relatório 07/2024). Lisboa.
4. Unidade Técnica de Apoio Orçamental. (2024). Relatório de execução financeira PPP: Janeiro-Junho 2023 . https://www.ers.pt/media/3452/ers_-_estudo_ppp.pdf
5. Serviço Nacional de Saúde (SNS) & BI dos Cuidados de Saúde Primários. (2024). Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, E.P.E. <https://bicsp.min-saude.pt/pt/biufs/3/832/Pages/default.aspx>
6. Tribunal de Contas. (2021). Relatório síntese: Parcerias público-privadas hospitalares no SNS . Tribunal de Contas. <https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/relatorios-oac/Documents/2021/relatorio-oac005-2021.pdf>
7. Entidade Reguladora da Saúde (ERS). (2016). Estudo de avaliação das parcerias público-privadas na saúde . ERS. https://www.ers.pt/media/3452/ers_-_estudo_ppp.pdf
8. Entidade Reguladora da Saúde (ERS). (2024). Cuidados de saúde primários - Qualidade e eficiência nas UCSP e USF . ERS. <https://www.ers.pt/pt/atividade/regulacao-economica/selecionar/estudos/lista-de-estudos/estudo-cuidados-de-saude-primarios-qualidade-e-eficiencia-nas-ucsp-e-usf/>
9. Pereira, A., et al. (2018). Avaliação de custos-consequências das USF B e UCSP 2015: Unidades Funcionais dos CSP como centros de resultados . Coordenação Nacional para a Reforma do SNS – Área dos Cuidados de Saúde Primários. SNS. https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2018/02/CNCSP-Avalia%C3%A7%C3%A3o_USF-1.pdf
10. Melo, M., & Sousa, J. C. D. (2011). Os indicadores de desempenho contratualizados com as USF: Um ponto da situação no actual momento da reforma. Revista Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, 27 (1), 28–34. <https://doi.org/10.32385/rpmgf.v27i1.10818>
11. Entidade Reguladora da Saúde (ERS). (2022). Setor convencionado de radiologia: Informação de monitorização . <https://www.ers.pt/media/ft4hdn5b/im-radiologia-2022-071223.pdf>

Anexos

Tabela 1 | Despesa média (em EUR) com medicamentos prescritos, comparticipados pelo SNS, por utente utilizador, 2019-2022.

Região de saúde	Tipo	2019	2020	Variação 2019-2020	2021	Variação 2020-2021	2022	Variação 2021-2022
Norte	UCSP	199,7	217,2	8,8%	219,9	1,2%	233,3	6,1%
	USF-A	167,4	191,0	14,1%	191,1	0,0%	213,4	11,7%
	USF-B	152,3	173,4	13,8%	170,4	-1,7%	183,6	7,8%
Total		171,2	191,6	11,9%	190,0	-0,8%	204,0	7,4%
Centro	UCSP	230,5	253,7	10,1%	239,9	-5,5%	234,6	-2,2%
	USF-A	201,9	226,2	12,0%	213,5	-5,6%	214,7	0,6%
	USF-B	173,5	195,7	12,8%	189,8	-3,0%	186,0	-2,0%
Total		210,4	233,4	10,9%	220,8	-5,4%	218,2	-1,2%
Lisboa e Vale do Tejo	UCSP	180,2	198,5	10,1%	181,9	-8,4%	193,4	6,3%
	USF-A	168,6	191,4	13,5%	183,3	-4,2%	203,8	11,2%
	USF-B	161,2	183,1	13,6%	175,1	-4,4%	187,4	7,0%
Total		170,6	191,4	12,2%	180,4	-5,8%	195,7	8,5%
Alentejo	UCSP	240,0	264,5	10,2%	252,4	-4,6%	261,9	3,8%
	USF-A	204,2	238,4	16,7%	226,7	-4,9%	242,3	6,9%
	USF-B	176,5	191,7	8,6%	187,6	-2,2%	209,6	11,8%
Total		223,8	249,1	11,3%	238,2	-4,4%	250,7	5,2%
Algarve	UCSP	199,5	212,6	6,6%	203,5	-4,3%	218,7	7,5%
	USF-A	156,1	178,6	14,4%	169,2	-5,2%	181,5	7,3%
	USF-B	144,6	162,5	12,3%	156,1	-3,9%	168,4	7,9%
Total		173,3	190,1	9,7%	180,5	-5,0%	193,4	7,1%
Portugal Continental		181,7	203,0	11,7%	195,4	-3,7%	206,6	5,7%
Teste Kruskal-Wallis - ARS (p-value)	500,275 (0,001)***							
Teste Kruskal-Wallis - Ano (p-value)	185,577 (0,001)***							
Teste Kruskal-Wallis - UF (p-value)	624,832 (0,001)***							

Fonte: ERS(2024) [8].

Tabela 2 | Despesa média (em EUR) com MCDT prescritos, por utente utilizador, com base no preço, 2019-2022.

Região de saúde	Tipo	2019	2020	Variação 2019-2020	2021	Variação 2020-2021	2022	Variação 2021-2022
Norte	UCSP	70,4	62,6	-11,0%	81,4	30,0%	81,5	0,1%
	USF-A	61,8	56,8	-8,1%	73,5	29,4%	77,3	5,2%
	USF-B	56,4	53,3	-5,6%	68,5	28,5%	66,3	-3,2%
Total		62,2	57,1	-8,3%	73,5	28,7%	73,0	-0,6%
Centro	UCSP	69,5	63,7	-8,3%	75,1	17,8%	74,9	-0,2%
	USF-A	67,2	61,9	-7,8%	75,7	22,2%	78,6	3,9%
	USF-B	59,7	56,5	-5,4%	68,7	21,6%	69,6	1,3%
Total		66,9	61,8	-7,7%	74,0	19,9%	75,1	1,5%
Lisboa e Vale do Tejo	UCSP	74,6	66,2	-11,3%	75,8	14,5%	81,9	8,0%
	USF-A	68,1	62,0	-8,9%	74,3	19,7%	78,6	5,9%
	USF-B	62,6	58,2	-7,1%	71,9	23,6%	73,8	2,6%
Total		68,8	62,3	-9,4%	74,0	18,8%	78,1	5,5%
Alentejo	UCSP	64,6	63,1	-2,4%	73,7	16,9%	73,3	-0,6%
	USF-A	55,7	60,9	9,4%	80,1	31,5%	68,1	-15,0%
	USF-B	52,4	57,7	10,2%	75,7	31,2%	67,0	-11,6%
Total		61,1	61,9	1,3%	75,3	21,7%	71,3	-5,3%
Algarve	UCSP	74,3	67,1	-9,7%	73,2	9,1%	79,5	8,7%
	USF-A	65,6	62,2	-5,2%	69,6	11,9%	68,3	-1,8%
	USF-B	55,7	52,0	-6,7%	63,9	22,9%	66,4	3,9%
Total		67,3	62,1	-7,8%	69,7	12,3%	72,4	3,8%
Portugal Continental		65,2	60,0	-7,9%	73,7	22,8%	74,8	1,5%
Teste Kruskal-Wallis - ARS (p-value)	84,646 (0,001)***							
Teste Kruskal-Wallis - Ano (p-value)	735,353 (0,001)***							
Teste Kruskal-Wallis - UF (p-value)	248,698 (0,007)***							

Fonte: ERS (2024) [8].

Eixo Estratégico 5 | Saúde Mental

Maria Cortes Ferreira

Tiago António

Sumário

Eixo Estratégico 5 Saúde Mental	53
1. Contextualização do problema	53
2. Apresentação sumária das medidas	55
3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica	56
4. Revisão ou Reforço das medidas propostas	60
Comentário Final	64
Referências	67

1. Contextualização do problema

Portugal é o país da UE com maior carga de problemas de saúde mental, com níveis de ansiedade e depressão entre os mais elevados [1]. No ano 2019, mais de 2,25 milhões de pessoas sofriam de uma perturbação de saúde mental, o que representava 22% da população, um valor superior à média de 16,7% da UE [2]; as perturbações de ansiedade foram as mais frequentes, afetando cerca de 9% da população, seguidas das perturbações depressivas (6%) e das perturbações associadas ao consumo de álcool e de drogas (4%). A taxa de suicídio em Portugal (8,9 por 100.000 em 2021), ainda que inferior à média dos países da EU, representa um problema de saúde pública significativo, nomeadamente pelo aumento da taxa de Anos de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) no sexo feminino (aumento de 6,6 %) [3]. O impacto dos problemas de saúde mental é socialmente desigual. As pessoas com baixos rendimentos têm maior prevalência de doença mental [1]. Por sua vez, a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental considera valores ainda mais elevados, com mais de três milhões de portugueses com doenças mentais, 17% com ansiedade e 8% com depressão. Em 2023, 34,3% da população portuguesa com mais de 16 anos tinha sintomas de ansiedade generalizada, dos quais 11,1% apresentavam níveis de ansiedade graves [4]. A determinação da população afetada por perturbações de saúde mental apresenta limitações metodológicas, que resultam numa subestimativa da verdadeira carga da doença. Não obstante essas limitações, a evidência aponta para um impacto de problemas de saúde mental muito significativo em Portugal. A nível do medicamento verifica-se um consumo de psicofármacos em Portugal elevado, face a outros países da UE, que aumentou nos últimos anos: entre 2017 e 2022 cresceu 45% [1].

Estas patologias impactam a qualidade de vida das populações e a economia, nomeadamente pelo absentismo laboral, presentismo e *turnover* de colaboradores. Em 2019, as perturbações de saúde mental resultaram na perda de quase 310 000 anos de

vida produtiva [1]. Segundo a OCDE, em 2015, os custos totais associados aos problemas de saúde mental em Portugal foram estimados em cerca de 3,7% do PIB, sendo mais de 40% desses custos atribuídos à redução da participação e da produtividade no mercado de trabalho [1, 5].

Segundo um estudo da Ordem dos Psicólogos Portugueses realizado com empresas não financeiras (não inclui a Administração Pública), os problemas relacionados com *stress* e saúde mental dos trabalhadores, nomeadamente absentismo, presentismo e quebras de produtividade, custam às empresas portuguesas até 5,3 mil milhões de euros por ano, uma subida face aos 3,2 mil milhões estimados no ano de 2022 [5]. Este trabalho, que analisa apenas os custos indiretos da saúde mental, estima que em Portugal os profissionais falem, devido ao *stress* e a problemas de saúde psicológica, até 8 dias por ano, e que o presentismo chegue até 15,8 dias. No total, a perda de produtividade pode custar às empresas portuguesas até 1,4% do seu volume de negócios. Os distúrbios do foro mental e comportamental apresentam um impacto na qualidade de vida da população, contribuindo para 8,9% dos anos de vida ajustados por incapacidade (DALY) e 17,7% dos anos de vida com incapacidade (YLD), destacando-se como uma das doenças não transmissíveis com maior impacto nestes indicadores [6].

De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, existem cerca 530 psicólogos afectos aos Cuidados de Saúde Primários e apenas 250 nos Centros de Saúde, número inferior a 1 por concelho, a nível nacional, e representando um rácio de 2,5 psicólogos/as para cada 100.000 utentes [7]. Para além dos psicólogos, também os assistentes sociais, técnicos de saúde ocupacional, bem como psiquiatras e pedopsiquiatras são um recurso escasso no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para responder às necessidades de cuidados. Neste sentido, considera-se a Resolução nº158/2021 da Assembleia da República sobre o rácio internacionalmente recomendado de psicólogos em contextos de saúde (1/5.000 habitantes) e sua distribuição territorial, havendo claramente um desequilíbrio entre oferta e procura.

A epidemiologia da doença mental e o reconhecimento da relevância da saúde mental na prosperidade dos países e na Sociedade tem feito desta área uma prioridade política ao longo dos anos. A nova Lei de Bases da Saúde (Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro) dedicou a Base 13 à Saúde Mental, sendo, entre outras, obrigação do Estado promover “a melhoria da saúde mental das pessoas e da sociedade em geral, designadamente através da promoção do bem-estar mental, da prevenção e identificação atempada das doenças mentais e dos riscos a elas associado”. Em 2021, com a publicação do Decreto-Lei 113/2021 foi estabelecida uma nova organização dos cuidados de saúde mental no âmbito do SNS, tendo sido criada a Coordenação Nacional para as Políticas de Saúde Mental e as Coordenações Regionais de Saúde Mental, responsáveis pela implementação coordenada de toda a reforma. Em 2022, a publicação do novo estatuto do SNS (Decreto-lei nº 52/2022 de 4 de agosto) atribui à Direção Executiva do SNS a competência de gerir a área da Saúde Mental (artº 1, alínea b). Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 102/2023, de 7 de novembro, que define o novo modelo de organização e de prestação de cuidados de saúde através da criação das Unidades Locais de Saúde (ULS). Este novo modelo visa melhorar o acesso da população aos cuidados de saúde, assegurando uma maior coerência a nível da coordenação clínica e de saúde pública.

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) (Mecanismo de Recuperação e Resiliência no Regulamento (UE) 2021/241, de 12 de fevereiro) tem como objetivo mitigar os

impactos da pandemia nas economias europeias. Na área da saúde mental o investimento definido foi de cerca de 88 milhões de euros, que representa cerca de 5% do investimento do PRR previsto para o Serviço Nacional de Saúde.

No contexto atual de grande reformulação do SNS e na sucessão de mudança governativa, nomeadamente com a tomada de posse do XXIV Governo Constitucional, foi elaborado o Plano de Emergência e Transformação na Saúde (doravante designado por Plano), que visa a implementação de medidas urgentes, prioritárias e estruturantes que garantam o acesso a cuidados de saúde ajustados às necessidades da população, rentabilizando e maximizando a resposta do SNS. O Plano integra 54 medidas que estão estruturadas em 5 Eixos Estratégicos de atuação, sendo o Eixo 5 – Saúde Mental (9 medidas) o foco desta análise. Tratando-se de um Plano de Emergência é esperado que permita dar resposta ao estado atual do Sistema Nacional de Saúde, nomeadamente atendendo às “áreas” de crise (por exemplo, dificuldades de acesso a cuidados de saúde) através de medidas urgentes e emergentes que deem respostas céleres que minimizem a degradação da realidade, e, por outro lado, permitam ao Sistema de Saúde evoluir no sentido de desenvolver uma nova estrutura que se adapte às necessidades presentes e futuras.

2. Apresentação sumária das medidas

No Eixo sobre Saúde Mental, o Plano assume como prioridade estratégica «Garantir o acesso a serviços habilitados a promover a saúde mental, prestando cuidados de qualidade, facilitando a reintegração e a recuperação das pessoas com doença mental». As medidas previstas neste plano são apresentadas sob a forma de (1) respostas urgentes (que requerem implementação imediata, com objetivo de obter resultados tangíveis num período máximo de 3 meses), (2) prioritárias (de elevada importância, para assegurar o atingimento dos objetivos de médio prazo, para produzir resultados até ao final de 2024) e, ainda, (3) medidas estruturantes (que correspondem ao pensamento estratégico e planeamento organizacional, fundamentais para a sustentabilidade e crescimento estrutural e transformação efetiva e profunda do futuro SNS).

Este Plano define como resultados esperados para a área da Saúde Mental (1) a contratação de psicólogos nos cuidados de saúde primários, (2) o desenvolvimento de programas de intervenção em ansiedade e depressão por equipas comunitárias de Saúde Mental e (3) a generalização dos Centros de Resposta Integrada de Saúde Mental. São definidas neste plano as seguintes medidas para a área da Saúde Mental:

Medidas		Prioridade	Estado
A.1	Contratação de psicólogos para os Cuidados de Saúde Primários	Urgente	Por iniciar
A.2	Criação de programa estruturado de Saúde Mental para as forças de segurança (PSP e GNR)	Urgente	Por iniciar
A.3	Desinstitucionalização de situações crónicas em saúde mental	Urgente	Em curso
B.1	Criação de Equipas Comunitárias de Saúde Mental para adultos, infância e adolescência	Prioritário	Em curso

B.2	Disponibilização de programas estruturados de intervenção na ansiedade e depressão nos Cuidados de Saúde Primários	Prioritário	Em curso
B.3	Garantia da capacidade de internamento para situações agudas nos Serviços Locais de Saúde Mental	Prioritário	Em curso
B.4	Criação de serviços de saúde mental regionais para internamento de doentes de elevada complexidade	Prioritário	Em curso
C.1	Construção dos serviços forenses no Hospital Sobral Cid e no Hospital Júlio de Matos	Estruturante	Em curso
C.2	Generalização dos Centros de Responsabilidade Integrados em todos os Serviços Locais de Saúde Mental	Estruturante	Em curso

Nota: O Estado das medidas refere-se a Julho de 2024.

Adicionalmente, a medida A.1 do Eixo 3 «Requalificação dos espaços dos Serviços de Urgência – Geral/Psiquiátrica» também é identificada como relevante, no contexto do Eixo estratégico da saúde mental.

Finalmente, como programa transversal de contingência, o Plano define a criação de um programa de valorização dos profissionais de saúde, que preconiza o investimento para a promoção de ambientes de trabalho saudáveis e satisfatórios, pautados por mecanismos de comunicação aberta e transparente, incluindo *feedback*, partilha regular de informação e implementação de canais de comunicação eficazes; simultaneamente, os profissionais de saúde devem ter acesso aos recursos necessários para realizar o seu trabalho de forma eficaz incluindo equipamentos adequados e apoio administrativo. Estas medidas têm o potencial para, de forma integrada com outras que compõem este programa transversal, melhorar a qualidade de saúde mental dos profissionais de saúde, um grupo profissional com fatores de risco específicos para a doença mental.

Algumas das medidas do Eixo 5 são financiadas pelo PRR, cerca de 88 milhões de euros, considerando assim que posteriormente podem vir a ser, eventualmente integradas no Orçamento de Estado ou, possivelmente, financiadas através de financiamentos estruturais», como por exemplo o PT2030. Não se encontraram referências ao financiamento das medidas deste Eixo no pós-2026.

3. Aplicação dos conceitos económicos e análise crítica

Numa avaliação empírica do impacto económico deste plano, pode esperar-se ganhos muito relevantes assumindo a sua implementação plena. Segundo o Relatório “Prosperidade e Sustentabilidade das Organizações” de 2023 [7], o reforço da promoção da saúde mental nas empresas pode reduzir a diminuição da produtividade em, pelo menos, 30% e, consequentemente resultar numa poupança de cerca de 1,6 mil milhões de euros por ano para as organizações, e consequentemente, para a economia.

Neste contexto, o custo de oportunidade do plano pode considerar-se relativamente baixo, face às consequências evitadas, resultantes da sua não-implementação e aos benefícios a médio e longo prazo, tanto diretos como indiretos, quer no sector da saúde, quer nos sectores de atividade onde os cidadãos se integram, aumentando a produtividade e reduzindo o absentismo e presentismo. Investir nesta área, e em particular nas medidas identificadas, contribui diretamente para a redução da carga destas doenças na população, contribuindo para a melhoria de resultados, não só em termos de esperança

média de vida como em termos de qualidade de vida. Em termos sociais, a intervenção em saúde mental, nomeadamente as intervenções comunitárias, podem também contribuir para uma redução de consumos abusivos, por exemplo de álcool, drogas.

A teoria da Economia da Saúde pode dar contributos úteis para a definição de políticas que produzam ganhos em saúde e garantam a sustentabilidade do sistema, justificando-se assim uma análise crítica das medidas inscritas no Plano nesta perspetiva, nomeadamente das incluídos no Eixo Estratégico 5 – Saúde Mental.

O Mercado da Saúde Mental: Relação Oferta - Procura

Atendendo à realidade portuguesa parecem existir disponíveis no mercado (e alguns em situações de desemprego) psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais capazes de integrar os serviços, nomeadamente os cuidados de saúde primários, conforme proposto neste plano, de forma a criar uma oferta de cuidados que se aproxime das necessidades e da procura existente na comunidade.

Esta oferta de serviços em quantidade adequada será fundamental para tornar os cuidados de saúde mental a nível dos cuidados de saúde primários efetivamente acessíveis, na medida em que correspondem a novos cuidados, que se pretende divulgar na comunidade, generalizando o seu acesso e inclusivamente “induzir” a sua procura, de forma a promover a adesão aos mesmos e a combater o estigma e o preconceito, permitindo que consigam efetivamente contribuir para os ganhos em saúde esperados, prevenindo a morbilidade e a mortalidade por doença mental, por outras patologias e reduzindo os impactos económicos associados à doença mental a curto, médio e longo prazo.

O aumento da oferta de cuidados de saúde mental é essencial para dar resposta à elevada procura, sendo também importante identificar e abordar a existência de barreiras ao acesso, nomeadamente financeiras, geográficas (resultantes de uma eventual insuficiente cobertura nacional) e barreiras relacionadas com a iliteracia e o estigma associados à doença mental.

Sendo a cobertura de cuidados de saúde mental ainda reduzida pelos seguros de saúde privados, e sendo a cobertura de seguros de saúde privados desigual na população, resultando potencialmente em baixa utilização dos mesmos pela população alvo, torna-se importante que este plano seja acompanhado de medidas adicionais que promovam a literacia, o conhecimento destes recursos e a adesão por parte daqueles a quem se dirigem.

Avaliação Económica do Impacto das Medidas

Muitas das medidas descritas no Plano são suportadas por evidência, de fácil implementação e populares junto da comunidade. Localmente, têm-se desenvolvido vários estudos com vista à compreensão do impacto e dos benefícios de medidas desta natureza: a OPP, por exemplo, tem desenvolvido análises que demonstram quais as intervenções terapêuticas mais efetivas e com maior impacto na saúde das populações. Constituem exemplos de avaliações económica de algumas destas medidas:

Medidas	Referência	Conclusões
A.1 B.1	Green 2014 [8]	Os cuidados colaborativos (incluindo psicólogos nos cuidados primários) permitem ganhos de saúde a custos relativamente baixos, e são custo-efetivos vs. cuidados convencionais, face a uma disponibilidade a pagar de £20,000/QALY.
A.3	Knapp 2011 [9]	Modelos comunitários não foram mais dispendiosos que modelos com base na institucionalização, mesmo após ajuste para as necessidades dos doentes e qualidade dos cuidados. Novos modelos comunitários poderão ser mais onerosos, ainda que custo-efetivos, dada a potencial melhoria de resultados.
B.2	Chisholm 2016 [10]	O tratamento da depressão e da ansiedade, em modelos que envolveram os cuidados de saúde primários, apresentou uma relação benefício-custo que variou entre 3,3:1 e 5,7:1, em países de diferentes níveis de rendimento.

Assim, existe evidência científica sugestiva do custo-efetividade de algumas destas medidas. No entanto, a interpretação desta evidência deve ser feita considerando as diferenças contextuais face à realidade nacional e às especificidades dos modelos avaliados face aos implementados localmente, sendo importantes avaliações adaptadas ao contexto nacional. Adicionalmente, é fundamental que estas medidas sejam definidas e implementadas como parte de um plano abrangente e integrado, que inclua a dimensão individual, organizacional e de saúde pública nacional, na medida em que os impactos económicos de cada medida são potencialmente transformados pela natureza estruturada em que é apresentada no Plano. Por este motivo, é fundamental que a implementação deste plano se acompanhe de um programa de monitorização de resultados e avaliação de ganhos em saúde e económicos, que permita a caracterização destes resultados, do impacto das medidas e do interesse e capacidade do seu alargamento a nível nacional. Para isso, será importante o envolvimento das várias entidades implicadas e com conhecimento nesta área, não só apenas como foi feita na estruturação do Plano, mas também ao longo da implementação e monitorização destas medidas.

Modelos de Financiamento – Relação de Agência nos Cuidados de Saúde Mental

O papel de agente que os profissionais de saúde desempenham perante o doente, que se traduz na tomada de decisões em seu nome, por deter mais conhecimento e informação sobre a sua saúde, resulta em potenciais conflitos durante a prestação de cuidados, na medida em que os profissionais também são sensíveis aos incentivos que recebem (vencimento, reputação, tempo disponível, etc); por outro lado, os doentes são limitados na sua capacidade de monitorizar adequadamente o esforço dos profissionais de saúde de atuar no seu melhor benefício, agravando-se no caso da doença mental como resultado do estigma e insegurança associados. Face a esta relação, os vários modelos de pagamento dos profissionais de saúde a definir, na área da saúde mental, apresentam potenciais vantagens e inconvenientes: enquanto o modelo de vencimento fixo previne a seleção de doentes, induz um risco de menor qualidade dos cuidados pela desmotivação do profissional, os modelos de *fee for service* podem incentivar a prestação de cuidados, mas resultar num excesso de consumo; por sua vez os modelos de capitação podem resultar numa alocação eficaz de recursos, mas também numa seleção, com base no risco dos doentes; finalmente, modelos de *pay-for-performance*, que podem complementar os modelos anteriormente descritos, incentivam cuidados de qualidade mas podem promover uma prática excessivamente centrada nos indicadores definidos e uma seleção dos doentes mais favorável à sua obtenção [11].

Assim, torna-se fundamental definir modelos inovadores de incentivos dos profissionais e de financiamento das instituições de saúde que promovam a qualidade, a eficácia, a justiça e a equidade.

O financiamento dos cuidados de saúde mental tem sido cronicamente insuficiente, apresentando uma tendência estável face ao crescimento dos problemas e graves assimetrias regionais na afetação de recursos. Em termos gerais do contexto do SNS pode inferir-se que apesar do aumento de profissionais e do número de horas contratadas não se verifica uma melhoria substancial no desempenho assistencial ou numa redução assinalável das necessidades da população [12]. Assim, e no atual contexto de emergência para a saúde, é necessário redefinir não só modelos de organização e funcionamento dos serviços, mas também modelos de financiamento às instituições e de remuneração aos profissionais de saúde no sentido promover o desenho e a qualidade dos serviços.

A reorganização do SNS, assente em ULS, prevê um novo modelo de financiamento baseado na estratificação do risco, em que cada ULS é financiada de acordo com o perfil de risco da sua população. Este novo modelo de financiamento pretende respeitar as necessidades de saúde dos utentes de cada ULS, fomentando a integração de cuidados, as intervenções preventivas, antecipatórias e mais adequadas ao bem-estar de cada um e, simultaneamente, robustecendo a capacidade de identificar precocemente situações de risco e necessidade de articulação com outros serviços de saúde e respostas sociais adequadas. Será, porém, importante que estes modelos de financiamento das ULS previnam e mitiguem o risco de seleção de doentes de menor risco (*cream skimming*).

Adicionalmente, a possibilidade da existência de Centros de Responsabilidade Integrados (CRI) de saúde mental a nível das ULS (Decreto-Lei nº118/2023), conforme previsto na medida C.2 do Plano, poderá proporcionar uma resposta à necessidade de definição de modelos de incentivos mais modernos para as equipas de saúde multidisciplinares que neles operam, contribuindo para o aumento da produtividade, motivação e realização dos profissionais que os integram. Os CRI são estruturas de gestão intermédia com autonomia funcional e técnica assente num compromisso assistencial e económico e financeiro entre os profissionais e as instituições. A existência de CRI de saúde mental permite um novo modelo de remuneração assente na definição de um salário base, um suplemento pelas horas extra e uma componente variável de incentivos associada ao desempenho (Portaria n.º 176/2022, de 7 de julho, que aprova as Tabelas de Preços das Instituições e Serviços Integrados no SNS e Portaria n.º 73/2024, de 29 de fevereiro, regulamenta o índice de desempenho da equipa e a atribuição dos incentivos institucionais). Este novo modelo tem a mais-valia de dar resposta aos profissionais de saúde mental que há muito criticavam o facto do modelo de contratualização e de pagamento das intervenções em saúde mental se manter inalterado, excessivamente centrado nos profissionais médicos, não prevendo a valorização da atividade de outros profissionais, e orientado quase exclusivamente para o pagamento de episódios das linhas de produção hospitalar, sem refletir as atividades de base comunitária [13]. Contudo, é necessário que a remuneração destes modelos não esteja apenas ligada à produção mas ao valor efetivamente gerado pelas intervenções realizadas. A área da saúde mental traduz-se em dificuldades adicionais tendo em consideração o desafio na definição de indicadores de resultados e o horizonte temporal no qual os mesmos são analisados.

4. Revisão ou Reforço das medidas propostas

Em complemento a esta análise crítica das medidas inscritas no Eixo Estratégico da Saúde Mental do Plano na perspectiva da Economia da Saúde, outras considerações podem ser feitas, com vista à construção de um plano com um maior impacto em termos de ganhos em saúde.

Intervenção em Grupos Profissionais – Critérios e Custo de Oportunidade

O trabalho com propósito é protetor da saúde mental, contribuindo para o sentido de realização e confiança individual, e para a recuperação e inclusão de pessoas que vivem com distúrbios psicossociais. No entanto, condições de trabalho nocivas e inadequadas, ambientes de trabalho perigosos, relações de trabalho débeis e o desemprego, agravado pela exposição prolongada a estes fatores, podem contribuir significativamente para a degradação da saúde mental ou o agravamento de condições mentais preexistentes [14]. Os espaços de trabalho seguros, saudáveis e inclusivos potenciam a saúde física e mental, e contribuem para a redução do absentismo, melhoram o desempenho profissional e a produtividade, aumentam a motivação e minimizam o conflito entre os colaboradores [14].

Assim, é justificada a orientação inscrita no Plano a nível da promoção, prevenção e intervenção na saúde mental de grupos profissionais vulneráveis como as forças de segurança; no entanto, não são claros os critérios e fundamentos que levam à seleção desta classe em detrimento de outras em risco, como os professores ou os profissionais de saúde. Estando a melhoria do ambiente de trabalho das instituições de saúde identificada como relevante para o sucesso deste plano, fará sentido considerar o seu impacto para a melhoria dos resultados em matéria de saúde mental também.

De uma perspetiva do benefício para as instituições de saúde enquanto empregadoras, por exemplo, a formação em competências de trabalho em equipa, dirigida aos colaboradores com responsabilidades de prestação de cuidados clínicos, demonstrou resultados positivos no funcionamento das equipas, mas também melhoria do desempenho técnico, aumento da eficiência e redução da ocorrência de erros clínicos. Alguns estudos sugerem a existência de benefícios clínicos associados a esta intervenção [15]. Muitos profissionais de saúde planeiam abandonar o seu local de trabalho, a organização ou mesmo o setor da saúde por completo [16]. Dados os desafios crescentes nas atividades de recrutamento, retenção e reativação dos profissionais de saúde, os serviços de saúde enfrentam riscos de disrupção da sua atividade, com adiamento de tratamentos eletivos, camas hospitalares desocupadas e os centros de cuidados primários e os serviços de urgência a operar perto, ou para além, da capacidade máxima. Estes constrangimentos interferem com a prestação de cuidados, mas em última análise desafiam os sistemas e a cobertura universal de saúde, transformando-se num problema de saúde pública [17]. O *burnout* em profissionais de saúde pode ter impactos adversos na qualidade dos cuidados prestados ao doente e na sua segurança, estando relacionado com práticas sub-ótimas nos cuidados ao doente e aumento do risco de erro médico e processos por má prática [18]. A rotatividade de profissionais apresenta também implicações financeiras para as instituições de saúde. Os custos da substituição de profissionais de saúde são elevados, variando em função da especialidade, localização e

duração do não-preenchimento da vaga; nos Estados Unidos, esta estimativa podia ascender a 1 milhão USD por profissional substituído [19]. Os profissionais com *burnout* e elevado volume de trabalho podem também gerar excesso da referenciação e da utilização de recursos, despesas associadas ao erro médico e processos por má prática, absentismo e baixa produtividade, resultando numa estimativa conservadora da rotatividade associada ao *burnout* superior a 5000 – 10000 USD por profissional, por ano [19].

Face ao apresentado recomenda-se ao decisor político a clarificação dos critérios subjacentes à seleção deste grupo de intervenção, bem como a definição de um painel de indicadores de processo e de resultados que permitam, de modo transparente, avaliar a implementação desta medida.

Monitorização de Resultados e Tomada de Decisões sobre Projetos-Piloto

Merecedor de atenção deve ser também o fato de alguns dos projetos a implementar e mencionados no Plano terem um carácter de projetos-piloto (duração de 10 meses, no caso da medida da criação dos Centros de Resposta Integrada, por exemplo), com potencial para apresentar um impacto significativo junto dos doentes e das suas famílias e alterar o atual paradigma de intervenção, ainda muito focada nos hospitais, e fomentar também as respostas de proximidade em ambiente comunitário, conforme recomendam as boas práticas. Nesse sentido, será importante identificar indicadores adequados e definir metodologias e critérios para avaliar os resultados e a eficiência dos processos; no entanto, para a saúde mental poderá ser difícil recorrer a indicadores de curto prazo que suportem esta avaliação e a tomada de decisão, dado o carácter de longo prazo da sua promoção, prevenção e intervenção.

Sendo compreensível, dado o contexto epidemiológico e a escassez de profissionais, o sentido de urgência e de oportunidade subjacentes à definição de um Eixo Estratégico dirigido à Saúde Mental no âmbito do Plano, dificilmente se conseguirá uma avaliação de resultados clínicos e melhoria de indicadores, a nível individual ou populacional, que efetivamente sustente um processo de tomada de decisão com celeridade e confiança.

Adicionalmente, e face ao exposto a respeito dos mecanismos de financiamento e de incentivo às instituições e aos profissionais de saúde implicados neste eixo, a identificação de indicadores de resultados fiáveis e consensuais será fundamental para os eventuais modelos a implementar.

O Plano em apreço visa ser um Plano de emergência, ou seja, dar resposta a uma situação de crise que ameaça o funcionamento normal do SNS e a saúde das populações. Neste sentido, os seus objetivos centram-se na contenção/redução dos danos e num retorno a um rápido equilíbrio. Apesar deste plano cumprir os princípios teóricos de um plano de emergência (horizonte temporal definido; procedimentos e ações específicas com interlocutores e responsabilidades bem definidas) pode problematizar-se sobre a inclusão do Eixo de Saúde Mental no Plano, especificamente sobre a aplicação de medidas que estavam desenhadas previamente [7,20]. Os resultados esperados a alcançar na área da saúde mental (por exemplo, com a contratação de Psicólogos nos Cuidados de Saúde Primários; Programas de intervenção em ansiedade e depressão por Equipas Comunitárias de Saúde Mental; generalização de CRI de Saúde Mental), sendo essenciais para melhorar o cenário epidemiológico da doença mental, apresentam um

sentido de emergência diferente dos restantes eixos que se focam em medidas operacionais para resolver e alterar insuficiências e ineficiências da realidade atual.

Recomenda-se ao decisor político a revisão do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, extensão a 2020, para estabelecer objetivos de longo prazo para esta área, promover a resiliência dos serviços de saúde mental e garantir a continuidade dos cuidados iniciados. Esta definição de objetivos é essencial para a tomada de decisão; no caso particular dos projetos pilotos, o planeamento para o futuro deve assentar no acompanhamento e definição de análises de impacto económico e de critérios de qualidade que orientarão a decisão sobre o alargamento a todo o país e a continuidade da implementação de medidas estruturantes. Por exemplo, a criação de 40 Equipas Comunitárias de Saúde Mental para adultos, infância e adolescência (meta i.3.04 que se relaciona com Medida B.1) está em curso, mas condicionada à publicação dos despachos que autorizam o recrutamento de recursos humanos.

Definição de Estratégias para o Estigma e Iliteracia como Barreiras ao Acesso

Sendo o estigma e a iliteracia em saúde mental barreiras ao acesso aos cuidados de saúde mental, torna-se imperativo considerar as suas implicações, inclusivamente a curto e médio prazo, bem como a definição de medidas no plano imediato, urgente e estruturante, nomeadamente ações de formação para profissionais e cidadãos que promovam a educação para a saúde e a qualidade dos cuidados clínicos prestados. As pessoas que vivem com distúrbios mentais são objeto de estigma e discriminação enraizados, resultantes do estereótipo gerado sobre a doença mental. Genericamente, assume-se que as pessoas que vivem com distúrbios mentais são preguiçosas, fracas, pouco inteligentes ou de relacionamento difícil, e que os distúrbios mentais são fraquezas de carácter, punições por comportamento imoral, forças sobrenaturais ou resultado do uso de substâncias ilícitas. A comunicação social pode contribuir para a perpetuação destas conceções erradas ao retratar as pessoas com distúrbios mentais como perigosas, irresponsáveis ou incapazes [21]. Consequentemente, as pessoas frequentemente decidem não procurar apoio, evitando a discriminação associada ao acesso aos cuidados de saúde mental [21].

Neste sentido recomenda-se ao decisor político o incentivo de atividades de Literacia em Saúde Mental no sentido de divulgar estes serviços e de promover uma adesão aos mesmo, tendo em vista também a intervenção e o diagnóstico precoce destas patologias.

Abordar o Papel dos Cuidadores Informais para o Sucesso do Plano

A Lei n.º 35/2023, de 21 de Julho, (Lei de Saúde Mental) dispõe sobre a definição, os fundamentos e os objetivos da política de saúde mental, consagra os direitos e deveres das pessoas com necessidade de cuidados de saúde mental, regula as restrições dos seus direitos e estabelece as garantias de proteção da liberdade e da autonomia destas pessoas. Esta Lei reflete o quadro valorativo à luz do qual devem ser entendidas todas as abordagens terapêuticas neste domínio, baseadas na dignidade da pessoa humana. No contexto da desinstitucionalização prevista nas medidas inscritas no Plano, torna-se fundamental identificar os interlocutores institucionais (Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Segurança Social (MTSS); Ministério da Administração Interna (MAI)) e dos utentes (cuidadores informais) implicados que serão determinantes para o seu sucesso e maximização do impacto e ganhos económicos, sociais e em saúde.

Para que as medidas de desinstitucionalização tenham sucesso e sejam efetivas, é necessário uma resposta individualizada que passe, idealmente, pela reinserção em meio familiar (com o acompanhamento dos serviços locais de saúde mental), pela instalação em estruturas residenciais, pela colocação em instituições de saúde ou em unidades da rede de cuidados continuados integrados de saúde mental, ou ainda, para quem não disponha de residência nem de apoio familiar, por uma resposta habitacional através da Segurança Social familiar (com o acompanhamento dos serviços locais de saúde mental). No caso das pessoas que necessitem de manter acompanhamento de saúde mental, este deverá ser sempre assegurado pelos serviços locais de saúde mental da área da residência. Destaca-se que o MAI, através da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), apenas intervirá enquanto entidade responsável pela execução de medidas de internamento, em casos de inimputabilidade, determinadas pelos tribunais. O acompanhamento das pessoas com perturbação mental competirá às áreas da Segurança Social (na medida em que as pessoas necessitem de integração em resposta social) e da Saúde (sendo, neste caso, assegurado o acompanhamento por parte dos serviços regionais e locais de saúde mental da área da futura residência).

A Lei n.º 100/2019 de 6 de setembro aprova o Estatuto do Cuidador Informal e estabelece um conjunto de requisitos de atribuição que se relacionam quer com as condições do cidadão candidato a Cuidador Informal quer com as características dos utentes que necessitam destes cuidados. Da leitura dos documentos disponíveis no site da Segurança Social pode inferir-se que o processo se destina mais a situações de psicopatologia pesada (por exemplo, esquizofrenias) e não às situações epidemiológicas mais prevalentes em Portugal (por exemplo, ansiedade e depressão). Neste sentido, e sabendo que um Plano de Emergência visa dar resposta a situações concretas de crise e desorganização, será pertinente que o legislador estude e implemente medidas de suporte aos cuidadores e familiares de cidadãos com doença mental e perturbação psicológica grave e prolongada no tempo, que não confira estatuto de dependência e que possa ser reversível (por exemplo, estatuto de cuidador informal por 6 meses para apoiar um familiar em *burnout*). Para além destas medidas, o Plano carece de medidas dirigidas ao envolvimento dos cuidadores das pessoas com doença mental, no sentido da sua capacitação, apoio psicológico e social e envolvimento na tomada de decisão, considerados fundamentais para o sucesso terapêutico [22]. Por outro lado, seria pertinente avaliar conjuntamente com a Ministério do Trabalho e Segurança Social o acesso às diferentes tipologias de resposta na RNCCI no âmbito da Saúde Mental. O presente Plano não explora os problemas de acesso, nem a distribuição geográfica destas respostas. Ora, considerando, por exemplo:

- i) o papel das equipas de saúde familiar da RNCCI de Saúde Mental a nível da prevenção de internamentos hospitalares e admissões em unidades residenciais;
- ii) a sinalização e encaminhamento de situações de descompensação para os Serviços Locais de Saúde Mental e apoiar a participação das famílias e outros cuidadores na prestação de cuidados no domicílio;

verifica-se que a cooperação interinstitucional com a Segurança Social é relevante pois as intervenções e os acompanhamentos são multidisciplinares e as unidades de internamento na RNCCI de Saúde Mental são geridas e financiadas pela Segurança Social. Neste sentido, considera-se que a implementação adequada de algumas destas medidas requer um envolvimento ativo da área governativa da Segurança Social,

devendo o impacto das mesmas em matéria de onerosidade recair sobre ambas as tutelas. A Medida A.3 (Desinstitucionalização de situações crónicas em saúde mental) será implementada, segundo informação de 2021 [23], com base em Estabelecimento de Protocolo e ou Acordo de Cooperação, com (i) Serviços públicos e pessoas coletivas de direito público, de direito privado e do setor social, preferencialmente da sua área geográfica de intervenção, e (ii) b) Associações representativas de utentes e ou familiares de pessoas com doença mental. Neste sentido, recomenda-se ao decisor que sejam estudados mecanismos que permitam às famílias acolher os seus familiares mitigando, por um lado o impacto económico para a família (por exemplo, se alguém tiver que abdicar do seu emprego ou trabalhar em *part-time*) e por outro que sejam desenvolvidas intervenções específicas que permitam minimizar o *burnout* e o risco de exclusão destes cuidadores.

Comentário Final

A análise do Eixo 5 do Plano de Emergência e Transformação na Saúde, especificamente das suas 9 medidas, permite concluir que pelo menos 8 destas medidas não são verdadeiramente novas, estando já de alguma forma previstas no Plano Nacional de Saúde Mental e no Plano de Recuperação e Resiliência. Conforme explicado no site da “Recuperar Portugal” o investimento na área da Saúde Mental, em sede PPR, está estreitamente ligado ao Plano Nacional de Saúde Mental.

Neste sentido, o Plano de Emergência tem a grande mais-valia de implementar medidas há muito solicitadas por utentes e profissionais do setor, mas que estavam pendentes de “apoio” político que permitisse a disponibilização das verbas necessárias à sua implementação. Em termos globais de política de saúde, será importante identificar os fatores na base da demora desta deliberação e implementação, de forma a poder atuar junto dos mesmos e executar efetivamente as medidas propostas e utilizar os mecanismos de financiamento aplicáveis. A título de exemplo, a modificação do modelo de gestão e organização dos serviços de saúde mental, bem como das bases em que assentam o pagamento dos serviços de saúde mental e o respetivo financiamento, pela constituição de Centros de Responsabilidade Integrada, dotados de orçamento próprio, já constava como recomendação no Relatório de Avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016, de julho de 2017, pela Comissão Técnica de Acompanhamento da Reforma de Saúde Mental [20]. Não obstante, a sua implementação continua a figurar no Plano. O recente Relatório 1/2024 da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR considerou preocupante o estado da execução das medidas previstas.

Considera-se, pois, que a inclusão destas medidas num dos Eixos do Plano de Emergência poderá ser determinante para a melhorar a execução financeira e física dos investimentos. Por outro lado, a CNA recomenda ao Governo e à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) a “... antecipação das questões relacionadas com financiamento plurianual, relativas a recursos humanos. Nesta questão, deve ser tomada especial atenção às necessidades, de modo que não se corram os riscos de existência de estruturas físicas e/ou equipamentos, sem os devidos recursos humanos que permitam a sua operação, inviabilizando a prestação desses cuidados de saúde às populações.”

Conforme apresentado no documento, algumas medidas do Plano já estavam previstas em documentos estratégicos anteriores, e a sua inclusão prevê uma dependência das verbas do PRR que vigora até 2026 e uma posterior transferência destes valores para o

Orçamento de Estado, sendo imperioso refletir sobre o valor do Orçamento de Estado de Saúde no Pós-PRR e a sua sustentabilidade a médio e longo prazo. Por exemplo, o PRR refere vários projetos relacionados com a criação das equipas comunitárias de saúde mental, em linha com a medida B.1 | Criação de Equipas Comunitárias de Saúde Mental para adultos, infância e adolescência, num valor agregado superior a €2,3 milhões. Ainda que parte desta verba se destine ao desenvolvimento da estrutura e aquisição e equipamentos, é inevitável antecipar que parte significativa corresponda a recursos humanos, os quais continuarão a figurar como despesa corrente de saúde nos anos subsequentes aos quais acresce os custos de manutenção destas estruturas. Ainda que a taxa de esforço desta rubrica possa ser de pequena dimensão face ao valor total do Orçamento de Estado para a Saúde (superior a €15 mil milhões em 2024), o conjunto de todas as medidas do Eixo 5 do Plano certamente pesará na despesa de saúde corrente do país. Destaca-se que 2 das 3 medidas urgentes (Medida A.1 | Contratação de psicólogos para os Cuidados de Saúde Primários e Medida A.2. | Criação de programa estruturado de Saúde Mental para as forças de segurança (PSP e GNR)), com um peso significativo nos custos do Plano, ainda se encontram por iniciar, enquanto as restantes estão em curso.

O planeamento e os estudos económico-financeiros associados a estas medidas são, de facto, essenciais sob pena de se estarem a realizar investimentos que não são sustentáveis no futuro, seja por falta de recursos humanos seja por falta de financiamento para os manter em funcionamento, defraudando assim as expectativas da opinião pública e não aumentando a prestação de cuidados de qualidade nestas áreas.

Não parece aceitável na realidade atual, com existência várias ferramentas tecnológicas de *business analytics and intelligence*, não existirem (ou não estarem divulgadas) o verdadeiro impacto destas medidas. Por outro lado, é essencial uma monitorização permanente das medidas de modo que seja assegurado que os orçamentos previstos em sede de PRR ou de Plano são cumpridos sem desvios.

Para além da sustentabilidade financeira devem ser implementados sistemas robustos de monitorização sistemática da avaliação de resultados, da eficácia, do custo-efetividade e do impacto das políticas, práticas e medidas implementadas neste Plano. Tais resultados devem ser do conhecimento público, tendo em vista a transparência e uma cultura de apresentação de resultados. Conforme menciona a CNA no seu relatório, a “dúvida sobre a realização, ou não, dos investimentos, é o pior serviço que pode ser prestado às populações, que ficam sem informação fidedigna sobre o que existe ou virá a existir, para seu apoio e dos seus familiares”.

A boa execução do PRR é essencial para modernizar o país, representando uma oportunidade para implementar as reformas estruturais necessárias, como é o caso da Saúde Mental. Conforme se mencionou acima pelo conjunto de reformas, de contratações, requalificação e expansão de infraestruturas deve ser equacionado o seu peso no orçamento de estado e avaliadas as possibilidades de manutenção e continuidade no pós-PRR, garantindo a sustentabilidade das intervenções agora iniciadas.

O Plano de Emergência e Transformação na Saúde, nomeadamente as medidas inscritas no Eixo Estratégico 5 da Saúde Mental, apresentam o potencial de contribuir para melhoria de resultados nesta área. Ainda assim, a evidência sobre a efetividade destas medidas e a sua sustentabilidade é escassa, e as implicações sobre o impacto da sua

transposição para o Orçamento de Estado são incertas. Os mecanismos de monitorização e avaliação serão essenciais para suportar a tomada das melhores decisões, bem como uma comunicação clara e uma adequada e regular apresentação de resultados que permita um verdadeiro exercício de transparência e democracia na Sociedade.

Referências

1. OCDE. (2024). State of Health in the EU - Portugal: Country Health Profile 2023 .
2. The burden of mental disorders, substance use disorders and self-harm among young people in Europe, 1990–2019: Findings from the Global Burden of Disease Study 2019. (2022). Lancet Regional Health Europe, 1 , 100341.
3. Direção-Geral da Saúde (DGS). (2022). Plano Nacional de Saúde 2021–2030 - Saúde Sustentável: de tod@s para tod@s .
4. Instituto Nacional de Estatística (INE). (2024). Estatísticas da saúde 2022 .
5. Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). (2023). Prosperidade e sustentabilidade das organizações: Relatório do custo do stress e dos problemas de saúde psicológica no trabalho, em Portugal .
6. de Almeida Simões, J., et al. (2017). Portugal: Health system review. Health Systems in Transition, 19 (2), 1–184.
7. Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP). (2022). Parecer OPP - Rácio dos psicólogos e psicólogas .
8. Green, C., et al. (2014). Cost-effectiveness of collaborative care for depression in UK primary care: Economic evaluation of a randomised controlled trial (CADET). PLoS One, 9 (8), e104225.
9. Knapp, M., et al. (2011). The economic consequences of deinstitutionalisation of mental health services: Lessons from a systematic review of European experience. Health & Social Care in the Community, 19 (2), 113–125.
10. Chisholm, D., et al. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: A global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry, 3 (5), 415–424.
11. Perelman, J., et al. (2018). Reforming the Portuguese mental health system: An incentive-based approach. International Journal of Mental Health Systems, 12 (25).
12. Conselho das Finanças Públicas (CFP). (2024). Evolução do desempenho do Serviço Nacional de Saúde em 2023 .
13. Xavier, M., et al. (2024). A Reforma da Saúde Mental em Portugal: Três anos de transformação . Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, Ministério da Saúde.
14. Organização Mundial da Saúde (OMS). (2022). WHO guidelines on mental health at work . Geneva: World Health Organization.
15. McCulloch, P., et al. (2011). Interventions to improve teamwork and communications among healthcare staff. British Journal of Surgery, 98 (5), 469–479.
16. International Council of Nurses. (2023). The global nursing shortage and nurse retention .
17. Kuhlmann, E., et al. (2023). The mental health needs of healthcare workers: When evidence does not guide policy. A comparative assessment of selected European countries. International Journal of Health Planning and Management, 39 , 614–636.
18. Søvold, L. E., et al. (2021). Prioritizing the mental health and well-being of healthcare workers: An urgent global public health priority. Frontiers in Public Health, 9 , 679397.
19. West, C. P., et al. (2018). Physician burnout: Contributors, consequences and solutions. Journal of Internal Medicine, 283 (6), 516–529.
20. Comissão Técnica de Acompanhamento da Reforma da Saúde Mental. (2017). Relatório da avaliação do Plano Nacional de Saúde Mental 2007-2016 e propostas prioritárias para a extensão a 2020. Ministério da Saúde.
21. World Health Organization. (2022). World mental health report: Transforming mental health for all (Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO). Geneva.

22. Cleary, M., et al. (2006). Carer participation in mental health service delivery. *International Journal of Mental Health Nursing*, 15 (3), 189–194.
23. Xavier, M., et al. (2021). Programa de desinstitucionalização em saúde mental. Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.

IPP POLICY BRIEF 16

Plano de Emergência para a Saúde

ISSN: 2183-9352

Outubro de 2024

Institute of Public Policy Lisbon – Rua Miguel Lupi 20, 1249-078 Lisboa PORTUGAL
www.ipp-jcs.org – email: admin@ipp-jcs.org – tel.: +351 213 925 986 – NIF: 510654320

As opiniões aqui expressas vinculam somente os autores e não refletem necessariamente as posições do Institute of Public Policy, da Universidade de Lisboa, ou qualquer outra instituição a que quer os autores, quer o IPP estejam associados. Nem o Institute of Public Policy nem qualquer representante seu é responsável pelo uso por terceiros da informação aqui contida. Este texto não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado sem autorização prévia e explícita dos seus autores. Quaisquer citações são autorizadas desde que a fonte original seja adequadamente reconhecida.



**INSTITUTE OF
PUBLIC POLICY**

L I S B O N